

AI Report

We are moderately confident this text is

AI Generated

AI Probability 66% This number is the probability that the document is AI generated, not a percentage of AI text in the document.	Plagiarism Plagiarism scan was not run for this document.
--	---

20240803029_Laporan Manajemen Proyek_Sistem Inform... - 7/22/2026

LAPORAN MANAJEMEN PROYEK

SISTEM INFORMASI REKAM MEDIS KLINIK PRATAMA

NAMA: Muhamad Alif Mandani

NIM: 20240803029

MATA KULIAH: Manajemen Sistem Informasi Proyek

JUDUL KASUS: Sistem Informasi Rekam Medis Klinik Pratama

DOSEN PENGAMPU: Jefry Sunupurwa Asri S.Kom., M.Kom.

PRODI SISTEM INFORMASI

UNIVERSITAS ESA UNGGUL

1

DAFTAR ISI

| DAFTAR ISI | 2 |

| --- | --- |

| BAB I PENDAHULUAN | 6 |

1.1 Latar Belakang Kasus 6
1.2 Rumusan Masalah 7
1.3 Tujuan Penulisan 7
BAB II ISI (PEMBAHASAN KASUS) 8
A. INISIASI PROYEK & BUSINESS CASE 8
A.1 Project Charter (Piagam Proyek) 8
A.2 Analisis Biaya-Manfaat 10
A.3 Stakeholder & Power/Interest Grid 12
B. PERENCANAAN LINGKUP & WBS 14
B.1 Work Breakdown Structure 14
B.2 Scope Statement 16
B.3 Product Backlog (Agile, MoSCoW) 17
C. PENJADWALAN, BIAYA, & METODOLOGI 18
C.1 Metodologi Hybrid (Agile-Waterfall) 18
C.2 Penjadwalan (Critical Path) 20
C.3 Estimasi Biaya Tiga Titik 22
D. MANAJEMEN RISIKO & KUALITAS 26
D.1 Risk Register 26
D.2 Expected Monetary Value (EMV) 27
D.3 Rencana Manajemen Kualitas 28
E. SDM, KOMUNIKASI, & PENGADAAN 29

2

E.1 Tim & Matriks RACI ... 29

E.2 Rencana Komunikasi ... 31

E.3 Pengadaan ... 32

F. IMPLEMENTASI, DEPLOYMENT, & PERUBAHAN ... 32

F.1 Strategi Go-Live: Big Bang ... 32

F.2 Migrasi Data ... 34

F.3 Pelatihan & Change Management ... 34

G. MONITORING, EVALUASI, & PENUTUPAN ... 35

G.1 Earned Value Management (Minggu ke-12) ... 35

G.2 Project Closure Checklist ... 36

G.3 Rencana Pemeliharaan (1 Tahun) ... 38

DAFTAR PUSTAKA ... 39

LAMPIRAN ... 40

3

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.

1 Ringkasan Project Charter Pengembangan Sistem Rekam Medis Elektronik ... 10

Gambar 2.

2 Visualisasi Analisis Biaya dan Manfaat Proyek ... 11

Gambar 2.

3 Pemetaan Stakeholder Berdasarkan Matriks Power-Interest ... 13

Gambar 2.

4 Diagram Work Breakdown Structure (WBS) Proyek ... 15

Gambar 2.

5 Diagram Metodologi Hybrid Agile-Waterfall pada Proyek Pengembangan Sistem

Rekam Medis Elektronik ... 20

Gambar 2.

6 Gantt Chart Jadwal Proyek Pengembangan Sistem Rekam Medis Elektronik ... 22

Gambar 2.

7 Gaji Rata-Rata Profesi IT ... 23

Gambar 2.
8 Harga Storage ... 24

Gambar 2.
9 Harga VPS ... 24

Gambar 2.
10 Diagram Estimasi Tiga Titik (PERT) untuk Estimasi Biaya Proyek ... 25

Gambar 2.
11 Matriks Probability-Impact Risiko Proyek Pengembangan Sistem Rekam Medis

Elektronik ... 27

Gambar 2.
12 Diagram Alur Quality Assurance pada Proyek Pengembangan Sistem Rekam

Medis Elektronik ... 29

Gambar 2.
13 Matriks RACI Proyek Pengembangan Sistem Rekam Medis Elektronik ... 31

Gambar 2.
14 Diagram Alur Cutover Go-Live Proyek Pengembangan Sistem Rekam Medis

Elektronik ... 33

Gambar 2.
15 Grafik Earned Value Management (EVM) Proyek Pengembangan Sistem Rekam

Medis Elektronik ... 36

4

DAFTAR TABEL

| Tabel 2.
1 Prioritas Pengembangan Fitur Menggunakan Metode MoSCoW | 18 |

| --- | --- |

| Tabel 2.
2 Work Breakdown Schedule (WBS) Proyek Pengembangan Sistem | 21 |

| Tabel 2.
3 Estimasi Biaya Pengembangan Modul Menggunakan Metode PERT | 22 |

| Tabel 2.
4 Estimasi Biaya Sumber Daya Manusia (SDM) Proyek | 24 |

| Tabel 2.
5 Estimasi Biaya Infrastruktur Sistem per Tahun | 25 |

| Tabel 2.
6 Risk Register Proyek Pengembangan Sistem | 27 |

| Tabel 2.
7 Matriks RACI Proyek Pengembangan Sistem | 30 |

| Tabel 2.
8 Rencana Manajemen Komunikasi Proyek | 31 |

| Tabel 2.
9 Rencana Pelatihan Pengguna Sistem | 34 |

| Tabel 2.
10 Indikator Earned Value Management (EVM) Proyek | 35 |

5

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Kasus

Bayangkan antrian pasien yang tak henti-henti di Klinik Pratama LKC DD; delapan puluh, sembilan puluh, terkadang seratus orang setiap harinya.

Mereka bergiliran datang, sementara staf medis tetap berjuang dengan tumpukan berkas kertas yang mudah rusak, bahkan hilang.

Sungguh risikonya mengerikan.

Obat rekam medis lenyap?

Apakah klaim BPJS ditolak karena catatan manual yang bertele-tele?

Itu hanya puncak gunung es.

Yang lebih mengkhawatirkan lagi adalah klinik ini nyaris siap menyambut gelombang regulasi digital yang sedang menggerakkan negeri ini.

Saya menyampaikan tentang Permenkes Nomor 24 Tahun 2022 dan KMK Nomor 1423 Tahun 2022.

Aturan dua ini tidak main-main, mewajibkan setiap fasilitas kesehatan, sekecil mana pun, harus mengintegrasikan datanya ke platform SATUSEHAT.

Tegas dan tak kompromi.

Di bawah tekanan yang demikian besar, pimpinan klinik akhirnya sampai pada titik keputusan yang krusial: membangun sistem rekam medis elektronik secara mandiri.

Bukan pilihan instan, melainkan sebuah keharusan.

Merancang modul yang cukup komprehensif mulai dari pendaftaran yang luwes, skrining dengan alarm darurat, SOAP terintegrasi dengan kode ICD, e-resep terhubung dengan farmasi, hingga billing yang efisien.

Yang tak kalah pentingnya juga: jembatan penghubung ke BPJS P-Care dan SATUSEHAT, tentunya dengan standar FHIR R4 yang terkini.

Namun, proyek sebesar ini pasti melibatkan banyak pihak, mulai dari dokter dan perawat hingga farmasi, bahkan lembaga pengawas seperti BPJS Kesehatan dan Kementerian Kesehatan.

Dengan sebanyak itu pemangku kepentingan, rasanya seperti menari di atas panggung yang ramai.

Kebutuhan akan pendekatan manajemen proyek yang terstruktur.

Jika target strategis tercapai, anggaran terkendali, tenggat waktu tidak molor, dan yang terpenting, kepatuhan regulasi serta kualitas layanan masih terjaga.

Studi kasus ini tidak hanya sekadar untuk mendokumentasikan langkah-langkah teknis.

Kami ingin menggali lebih dalam, menelusuri seluruh siklus proyek dari benih ide hingga sistem dapat berjalan. Dari tahap inisiasi yang penuh pertimbangan, hingga penutupan proyek yang seringkali dilupakan begitu saja. Sebagai kerangka pemikiran, kami mengacu pada PMBOK Guide edisi ketujuh yang diterbitkan oleh PMI (2021), sekaligus menyertakan temuan-temuan ilmiah terkini terkait penerapan rekam medis elektronik di fasilitas kesehatan primer. Sebab, akhirnya,

6

keberhasilan proyek bukan hanya tentang kode, melainkan tentang kesiapan manusia, proses, dan kepatuhan yang tak berbelah-belah.

1.2 Rumusan Masalah

Dari penjelasan latar belakang tersebut, terdapat lima pertanyaan utama yang menjadi peta jalan studi kasus ini. Pertama, bagaimana proses inisiasi proyek dan analisis kelayakan disusun?

Bukan hanya soal angka-angka finansial, tetapi juga pertimbangan strategis yang memastikan proyek RME ini benar-benar layak dilakukan.

Kedua, bagaimanakah lingkup pekerjaan, jadwal, dan biaya dapat direncanakan secara realistis mengingat sumber daya klinis yang tidak terlalu besar?

Ini soal menyusun puzzle dengan potongan yang terbatas.

Ketiga, risiko dan kualitas biasanya menjadi momok dalam proyek seperti ini.

Bagaimana kedua-duanya dikelola untuk tidak mengganggu pelayanan klinis yang sudah berjalan?

Pasien tidak bisa menunggu, kan?

Keempat, sistem apa pun sekencang mana pun tidak akan berguna jika pengguna tidak mau menggunakannya.

Maka pertanyaan keempat mengusuk: bagaimana strategi implementasi, pelatihan, dan manajemen perubahan dirancang untuk memaksimalkan penerimaan, bahkan antusiasme, dari para pengguna?

Kedua, bagaimana proses pemantauan dan evaluasi kinerja proyek di tengah jalan, serta cara penutupan dilakukan agar tidak ada yang terlewat?

Rumusan masalah ini menjadi kompas untuk menuntut seluruh analisis dalam studi kasus ini, memastikan tidak ada sudut yang terlewat dari pengelolaan proyek yang kompleks dan krusial ini.

1.3 Tujuan Penulisan

Tujuan yang ingin dicapai dalam studi kasus ini cukup banyak, tetapi saling terkait.

Pertama-tama kami ingin menjelaskan seluruh proses inisiasi proyek.

Bukan hanya prosedur saja, tetapi juga penyusunan project charter dan analisis biaya manfaat yang menjadi dasar pengambilan keputusan investasi.

Sesiapa yang ingin rugi?

Oleh itu, semuanya perlu dihitung matang-matang.

Kedua, perencanaan lingkup kerjanya.

Kami akan memecahnya dengan Work Breakdown Structure dan scope statement.

Yang kedua, alat ini sebagai pagar pembatas agar ruang gerak proyek tidak terlalu lebar ke mana-mana.

Kemudian, kami menggambarkan metodologi yang telah dipilih, melacak jalur kritis penjadwalan, dan menghitung perkiraan biaya.

Untuk klinik

7

kecil, ketepatan waktu dan anggaran adalah nyawa proyek.

Analisis risiko dan rencana kualitas menjadi lapisan pertahanan selanjutnya.

Kita akan menelusuri keduanya secara mendalam, karena gangguan pada pelayanan klinis adalah harga mati yang tak boleh dibayar.

Di sisi lain, kita akan menggambarkan pengelolaan sumber daya manusia, komunikasi, dan pengadaan.

Ketiga pilar ini sering kali terabaikan, padahal justru menjadi penentu kelancaran sehari-hari.

Tak berhenti di situ.

Penyelasan juga akan diberikan secara singkat mengenai strategi pelaksanaan, migrasi data, dan manajemen perubahan.

Bagaimana cara untuk membantu seluruh tim beradaptasi?

Tantangan itu tersendiri.

Dan sebagai langkah terakhir, kami akan mengevaluasi kinerja proyek dengan menggunakan Earned Value Management.

Kami juga membahas penutupan proyek serta pemeliharaan pasca implementasi karena sungguh-sungguh fase pemeliharaan merupakan awal dari perjalanan panjang sistem itu sendiri

BAB II ISI (PEMBAHASAN KASUS)

A. INISIASI PROYEK & BUSINESS CASE

A.1 Project Charter (Piagam Proyek)

Visi besar ini tidak sekadar omong-omong.

Klinik Pratama LKC DD memiliki cita-cita untuk berubah menjadi Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama yang modern, efisien, serta patuh terhadap aturan digital kesehatan nasional.

Dan itu tidak boleh menjadi pilihan.

Kewajiban ini langsung berasal dari Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis.

Aturannya sangat tegas: semua fasilitas kesehatan harus menyelenggarakan RME dan mengoneksikan datanya ke platform SATUSEHAT.

Belum cukup, KMK Nomor HK.01.07/MENKES/1423/2022 juga mengatur pedoman variabel dan metadata yang harus diikuti.

Jadi ini bukan masalah gaya, tapi kepatuhan mutlak.

Penelitian lapangan di klinik-klinik pratama sejenis mengungkap fakta yang menarik, bahkan mengejutkan.

Ternyata kesiapan infrastruktur teknologi informasi menjadi faktor yang paling dominan.

Angkanya Odds Ratio mencapai 20,26.

Perbandingan dengan faktor SDM atau budaya kerja yang nilainya jauh lebih rendah.

Yakni infrastruktur bukan sekadar pelengkap, melainkan penentu utama.

Maka investasi dalam proyek ini bukan hanya soal membeli perangkat keras atau lunak saja.

Sebagai tambahan, investasi ini menjadi fondasi kepatuhan untuk

8

mendukung seluruh operasional klinik di masa depan.

Tanpa dasar itu, segala usaha itu tak lain adalah sia-sia.

Lalu apa yang akan dibangun?

Ruang lingkup tingkat tinggi telah dirancang.

Sistem RME berbasis web dengan modul yang cukup lengkap seperti pendaftaran yang fleksibel, bisa menerima NIK, paspor, SIM, bahkan pasien tanpa identitas.

Skrining tanda vital dilakukan secara manual, namun dilengkapi dengan alarm kegawatdaruratan yang cepat.

Modul SOAP menyediakan autocomplete untuk kode ICD-10 dan ICD-9-CM yang memudahkan dokter dalam menetapkan diagnosis.

E-resep terintegrasi langsung dengan Kamus Farmasi dan Alat Kesehatan (KFA), sedangkan input alergi menggunakan standar SNOMED CT.

Tersedia juga farmasi dan billing sederhana.

Yang tak kalah penting, sistem ini dilengkapi dengan bridging BPJS P-Care dan pengiriman data ke SATUSEHAT berbasis standar FHIR R4.

Infrastruktur pendukungnya juga disiapkan: VPS dengan spesifikasi 2 vCPU, RAM 8 GB, penyimpanan NVMe 120 GB, beserta backup harian terenkripsi yang disimpan di luar server.

Lengkap kan?

Namun perlu dicatatlah bahwa terdapat batasan eksplisit yang tidak termasuk dalam lingkup proyek.

Pasien tidak memiliki aplikasi seluler.

Tidak ada kios untuk pendaftaran mandiri.

Diskon, paket layanan, modul akuntansi lengkap, integrasi alat medis otomatis, atau layanan telemedicine juga tidak ada.

Keputusan ini diambil secara sadar untuk menjaga fokus dan efisiensi mengingat keterbatasan sumber daya yang dimiliki.

Faktor Keberhasilan Kritis

Kepatuhan mutlak.

Tanpa tawar-menawar.

Data diagnosis, tindakan, obat, dan alergi wajib meluncur ke SATUSEHAT dalam kondisi prima.

Tak boleh ada satu butir pun yang tercecer.

Begini kerasnya tuntutan interoperabilitas.

Adopsi pengguna.

Dua pekan pertama adalah masa genting.

Dokter dan perawat harus lekas akrab dengan sistem, dan lebih menantang lagi, tanpa mengorbankan produktivitas. (Mereka tetap melayani pasien dengan kecepatan yang sama, atau justru lebih efisien.

Mampukah?

Ini pertarungan yang sesungguhnya.)

Kestabilan terintegrasi dengan BPJS.

Downtime tidak boleh menembus satu persen.

Angkanya kecil, tetapi konsekuensinya ganas bila dilanggar.

9

Keamanan informasi.

Setiap backup harus berhasil.

Enkripsi data tersimpan menjadi benteng pamungkas, dan jejak audit harus tak terbantahkan.

Dan keempat pilar ini menjadi fondasi.

Penopang kepercayaan dari semua pihak.

Risiko Tingkat Tinggi

Resistensi dokter terhadap alur kerja baru.

Perubahan API SATUSEHAT secara mendadak.

Kompetensi developer pada standar FHIR/ICD.

Koneksi internet klinik yang labil.

Manajer proyek memegang peran sentral.

Wewenang yang diberikan cukup luas: mengelola anggaran dengan diskresi hingga 15 persen, merekrut atau mem-berhentikan tim kontrak, menyetujui perubahan lingkup selama masih di bawah 5 persen, dan berkomunikasi langsung dengan sponsor.

Ini adalah kepercayaan besar, tapi juga tanggung jawab yang berat.

Keputusan-keputusan strategis ada di tangannya, dan setiap langkah harus dipertimbangkan dengan cermat.

Gambar 2.

1 Ringkasan Project Charter Pengembangan Sistem Rekam Medis Elektronik

A.2 Analisis Biaya-Manfaat

Manfaat Tangible (per tahun):

Hemat kertas & cetak: Rp 18.000.000

Pengurangan klaim BPJS tertunda: Rp 24.000.000

10

Tambahan pasien (± 5 /hari): Rp 30.000.000

Total: Rp 72.000.000

Tapi masih ada manfaat lain yang tidak terlihat, namun sama pentingnya.

Reputasi digital klinik ikut terdongkrak.

Proses audit jadi lebih mudah.

Pasien pun merasa lebih puas.

Staf tidak lagi sibuk mengurus pekerjaan administratif yang itu-itu saja, melainkan bisa lebih fokus melayani pasien secara langsung.

Itu nilai tambah yang sulit diukur dengan uang, tapi sangat teras.

Sekarang bandingkan dengan biayanya:

Perhitungan:

Biaya proyek (investasi awal): Rp 113.000.000

Pemeliharaan tahunan (15%): Rp 16.950.000

Biaya tahun pertama: Rp 129.950.000

Manfaat bersih tahun pertama: Rp 55.050.000 (Rp 72.000.000 – Rp 16.950.000)

Payback Period: 1,57 tahun

ROI 3 tahun: 47%

Kesimpulannya?
LAYAK.

Keuntungan nyata menggulung ongkos operasional.

Dan ini yang kerap dilupakan: risiko sanksi administratif akibat ketidakpatuhan terhadap Permenkes 24/2022 justru jauh lebih menguras.

Teguran tertulis, pembatasan layanan, hingga pencabutan izin sesuai Pasal 41 (mengerikan, bukan?) bisa menimpa klinik yang lalai.

Balancing IT Project Costs and Benefits

Gambar 2.
2 Visualisasi Analisis Biaya dan Manfaat Proyek

11

Studi evaluasi ekonomi dari Singapura turut menegaskan.

Chen dan kawan-kawan (2025) dalam JMIR Medical Informatics membeberkan bahwa manfaat RME pada layanan primer memang hadir, meskipun dalam jangka pendek masih tergolong marginal.

Namun manfaat optimal baru beranjak ketika sistem sungguh-sungguh dimanfaatkan untuk memangkas duplikasi pemeriksaan yang kerap tak disadari itu.

dan mempercepat alur klaim.

Temuan ini sejalan dengan estimasi payback 1,57 tahun pada proyek kita, yang memang bertumpu pada efisiensi klaim dan peningkatan jumlah kunjungan pasien.

A.3 Stakeholder & Power/Interest Grid

Ada delapan pemain kunci dalam proyek ini.

Mereka bukan sekadar daftar nama, melainkan pihak-pihak yang punya kepentingan dan pengaruh besar terhadap jalannya sistem.

Mulai dari Direktur Klinik yang bertindak sebagai sponsor, Dokter Umum selaku DPJP, perawat dan petugas pendaftaran, farmasi, admin IT, BPJS Kesehatan cabang, Kementerian Kesehatan melalui platform SATUSEHAT, hingga pasien yang diwakili oleh perwakilannya.

Masing-masing punya peran yang tak bisa diabaikan.

8 Stakeholder Kunci:

Direktur Klinik (Sponsor)

Dokter Umum (DPJP)

Perawat/Pendaftaran

Farmasi

Admin IT

BPJS Kesehatan cabang

Kementerian Kesehatan (SATUSEHAT)

Pasien (perwakilan)

Sekarang, bagaimana strategi menghadapi mereka?

Kita bagi berdasarkan tingkat kekuasaan dan kepentingan.

Direktur dan dokter berada di kuadran paling kritis: kekuasaan tinggi, kepentingan tinggi.

Mereka harus dikelola secara intensif.

Laporan mingguan menjadi rutinitas yang tak bisa ditawar.

Bahkan, mereka punya hak veto terhadap desain antarmuka SOAP.

Suara mereka sangat menentukan.

12

Grid dan Strategi:

High Power, High Interest (Direktur, Dokter): kelola mereka dengan intens.

Mereka punya kuasa besar dan perhatian yang sangat tinggi terhadap proyek ini.

Laporan mingguan menjadi kewajiban rutin.

Dan yang menarik, mereka memegang hak veto terhadap desain antarmuka SOAP.

Setiap perubahan pada modul itu harus mendapat lampu hijau dari mereka.

Tanpa restu mereka, semua usaha hanya akan sia-sia.

High Power, Low Interest (Kemenkes, BPJS): Kementerian Kesehatan dan BPJS.

Kekuasaan mereka juga tinggi, tapi kepentingan terhadap detail teknis justru rendah.

Strategi yang tepat: jaga mereka tetap puas.

Patuhi regulasi tanpa banyak tawar-menawar.

Jangan pernah membebani mereka dengan urusan internal yang rumit.

Biarkan mereka fokus pada kepatuhan, bukan pada seluk-beluk kode.

Low Power, High Interest (Perawat, Farmasi, Admin IT): Mereka punya kepentingan tinggi, namun kekuasaan relatif rendah.

Mereka adalah ujung tombak operasional.

Beri mereka informasi secara teratur.

Daily standup selama 15 menit setiap hari.

Demo awal untuk menunjukkan alur sistem.

Survei umpan balik untuk menangkap keluhan dan saran mereka.

Karena mereka yang akan merasakan langsung setiap perubahan di lapangan.

Low Power, Low Interest (Pasien): Kekuasaan dan kepentingan mereka tergolong rendah dalam konteks pengembangan proyek.

Pemantauan dilakukan secara pasif melalui kotak saran dan pengukuran waktu tunggu.

Komunikasi tidak perlu intensif, cukup dengan papan informasi sederhana.

Mereka adalah konsumen akhir yang akan merasakan dampaknya, baik langsung maupun tidak langsung.

Gambar 2.

3 Pemetaan Stakeholder Berdasarkan Matriks Power-Interest

13

B. PERENCANAAN LINGKUP & WBS

B.1 Work Breakdown Structure

Mari kita bedah struktur rincian kerja proyek ini.
Ini adalah tulang punggung dari keseluruhan perencanaan.
Berikut struktur rincian kerja proyek ini:

1. Inisiasi Proyek

Semua dimulai dari fase inisiasi.
Di sini, tim menyusun piagam proyek dan kasus bisnis.
Ada riset regulasi yang mendalam, wawancara dengan berbagai pihak, penulisan dokumen yang ketat, dan tentu saja proses otorisasi.
Tidak berhenti sampai di situ, rekrutmen tim juga berjalan paralel.
Deskripsi pekerjaan disusun, lowongan dipasang, wawancara dilakukan, dan kontrak ditandatangani.
Dua langkah awal yang sangat menentukan.

2. Analisis & Desain

Ada tiga sub-bagian penting.
Pertama, analisis kebutuhan dengan memetakan alur klinis yang ada, mengidentifikasi celah-celah regulasi, dan merumuskan cerita pengguna.
Kedua, desain basis data.
Ini meliputi pembuatan ERD konseptual, normalisasi dan skema fisik, hingga skrip DDL untuk PostgreSQL.
Ketiga, desain antarmuka pengguna.
Mulai dari wireframe resolusi rendah hingga resolusi tinggi untuk lima layar kunci, yang kemudian divalidasi langsung oleh dokter.
Tahap ini adalah jembatan antara konsep dan implementasi.

3. Pengembangan Modul Inti

Ini adalah bagian yang paling luas dan memakan waktu.
Infrastruktur dan DevOps harus disiapkan terlebih dahulu: provisioning VPS, pengaturan PostgreSQL dengan RBAC dan backup, hingga CI/CD sederhana.
Data master diimpor dari berbagai sumber, termasuk ICD-10, ICD-9-CM, dan KFA.
Fungsi CRUD untuk pasien, dokter, dan obat juga dibangun, dengan dukungan identitas yang fleksibel.
Modul pendaftaran dan skrining dirancang dengan form pendaftaran yang efisien, pencatatan tanda vital disertai alarm darurat, dan antrian dokter yang diperbarui secara real-time.
Modul SOAP menjadi pusat dokumentasi klinis, dilengkapi autocomplete untuk kode diagnosis dan tindakan, e-resep berbasis KFA, serta input alergi menggunakan SNOMED CT.
Farmasi dan billing mengelola antrian resep

14

dan stok obat, serta menangani pembayaran tunai dan BPJS.
Integrasi dengan BPJS mencakup verifikasi SEP dan rujukan, baik FKTP maupun darurat.
Terakhir, integrasi SATUSEHAT melalui mapping FHIR, pengiriman data dan pencatatan log, serta dasbor pemantauan.

4. Pengujian

Setelah semua modul dibangun, pengujian dilakukan secara menyeluruh.
Ada unit test dan integration test, system test untuk performa dan keamanan, UAT yang melibatkan pengguna, dan uji sandbox dengan SATUSEHAT.

Semua harus berjalan mulus sebelum melanjutkan ke fase terakhir.

5. Deployment & Pelatihan

Migrasi data master dilakukan, pelatihan pengguna dijadwalkan, go-live dengan strategi Big Bang, dan hyper-care selama satu minggu penuh untuk memastikan transisi berjalan tanpa hambatan berarti. Ini adalah momen yang paling mendebarkan, sekaligus paling menentukan.

Gambar 2.

4 Diagram Work Breakdown Structure (WBS) Proyek

15

B.2 Scope Statement

Mari kita bahas ruang lingkup pekerjaan secara tegas.

Ini adalah pagar pembatas yang akan menjaga proyek tetap berada di jalurnya.

Ada tujuh modul yang masuk dalam cakupan wajib.

Pertama, pendaftaran dengan identitas fleksibel, bisa menerima berbagai jenis dokumen identitas.

Kedua, skrining tanda vital yang dilengkapi dengan alarm darurat, mengacu pada kriteria gawat darurat sesuai Permenkes 47 Tahun 2018.

Ketiga, modul SOAP yang mendukung diagnosis dengan kode ICD-10, tindakan dengan ICD-9-CM, dan resep berbasis KFA.

Keempat, pencatatan riwayat alergi menggunakan standar SNOMED CT.

Kelima, bridging dengan BPJS untuk verifikasi SEP dan rujukan.

Keenam, pengiriman data ke SATUSEHAT melalui standar FHIR R4 dengan delapan jenis sumber daya, mulai dari Patient, Encounter, Condition, Procedure, MedicationRequest, AllergyIntolerance, hingga Practitioner.

Ketujuh, billing sederhana yang dilengkapi kwitansi.

In-Scope (7 modul wajib):

Pendaftaran dengan identitas fleksibel.

Skrining tanda vital & alert darurat (mengacu kriteria gawat darurat Permenkes 47/2018).

SOAP dengan diagnosis ICD-10, tindakan ICD-9-CM, resep KFA.

Riwayat alergi SNOMED CT.

Bridging BPJS (verifikasi SEP, rujukan).

Kirim data FHIR R4 ke SATUSEHAT (resource: Patient, Encounter, Condition, Procedure, MedicationRequest, AllergyIntolerance, Practitioner).

Billing sederhana + kwitansi.

Lalu, apa yang tidak masuk?

Ada beberapa hal yang sengaja dikeluarkan dari lingkup.

Tidak ada self-registration untuk pasien.

Tidak ada aplikasi seluler.

Diskon dan paket layanan juga tidak tersedia.

Integrasi dengan alat medis otomatis dan modul akuntansi penuh juga dikesampingkan. Ini bukan kelalaian, melainkan keputusan sadar untuk menjaga fokus dan efisiensi.

Out-of-Scope:

Self-registration

Aplikasi seluler

16

Diskon

Integrasi alat medis

Akuntansi penuh.

Kriteria penerimaan pun disusun dengan jelas dan terukur. Kepuasan pengguna dalam UAT harus mencapai minimal 80 persen. Waktu respons sistem di bawah dua detik ketika diakses oleh delapan pengguna secara bersamaan. Bug kategori blocker harus nol, sedangkan bug major tidak boleh lebih dari tiga sebelum go-live. Pengiriman data ke SATUSEHAT harus berhasil seratus persen dari 50 sampel uji. Dan proses pemulihan backup tidak boleh memakan waktu lebih dari 30 menit. Semua angka ini menjadi tolok ukur keberhasilan.

Acceptance Criteria:

UAT pengguna: kepuasan $\geq 80\%$.

Waktu respons < 2 detik pada 8 pengguna bersamaan.

Blocker bug = 0, major < 3 sebelum go-live.

Kirim SATUSEHAT sukses 100% (50 sampel uji).

Restore backup < 30 menit.

B.3 Product Backlog (Agile, MoSCoW)

Sekarang beralih ke daftar prioritas produk dengan pendekatan Agile dan metode MoSCoW. Kategori Must berisi fitur yang mutlak harus ada: pendaftaran, skrining, SOAP, e-resep, billing, bridging BPJS, dan integrasi SATUSEHAT. Tanpa ini, sistem tidak bisa berfungsi sebagaimana mestinya. Kategori Should mencakup fitur penting tapi tidak kritis: impor CSV, diagnosis favorit, dan dasbor SATUSEHAT.

17

| Prioritas | Item |

| --- | --- |

| Must | Pendaftaran, Skrining, SOAP, e-Resep, Billing, Bridging BPJS, SATUSEHAT |

| Should | Impor CSV, Diagnosis Favorit, Dashboard SATUSEHAT |

| Could | Preferensi Poli/DPJP, Laporan Harian |

| Won't | Diskon, Paket Layanan, Self-registration, Aplikasi Seluler, Integrasi Alat |

Tabel 2.

1 Prioritas Pengembangan Fitur Menggunakan Metode MoSCoW

Kategori Could berisi fitur tambahan yang bersifat pelengkap, seperti preferensi poli atau DPJP dan laporan harian. Sementara kategori Won't adalah fitur yang tidak akan dikerjakan, termasuk diskon, paket layanan, self-registration, aplikasi seluler, dan integrasi alat medis.

Semua ini adalah hasil diskusi tim yang matang.

Kita memilih untuk menjaga ruang lingkup tetap ramping, fokus pada proses bisnis inti yang sederhana namun penting: pendaftaran, pemeriksaan, pemberian obat, dan pembayaran.

Itulah denyut nadi klinik yang harus kita layani dengan baik.

C. PENJADWALAN, BIAYA, & METODOLOGI

C.1 Metodologi Hybrid (Agile-Waterfall)

Mengapa metode hybrid menjadi pilihan?

Bukan tanpa alasan.

Kami punya lima pertimbangan matang, dan semuanya bermuara pada satu titik: kebutuhan lapangan yang tak bisa dipaksa masuk ke satu kotak kaku.

Lima Alasan Pemilihan:

Kebutuhan klinis bersifat dinamis, membutuhkan sprint pendek untuk iterasi cepat.

Ukuran tim kecil (4-5 orang) lebih cocok dikelola dengan Scrum ringan.

Integrasi standar eksternal (FHIR, ICD, KFA) memerlukan spesifikasi yang kaku sejak awal.

Di situlah pendekatan waterfall kami pakai, terutama untuk desain basis data dan

18

pemetaan data.

Kami tidak bisa main-main dengan struktur tabel jika SATUSEHAT sudah menentukan formatnya.

Di sisi lain, regulasi seperti Permenkes 24/2022 dan KMK 1423/2022 juga berpotensi mengalami pembaruan.

Jika kami memakai waterfall murni, perubahan aturan di tengah jalan bisa menjadi bencana.

Maka, sprint review berkala menjadi kartu as kami untuk menangkap revisi aturan lebih cepat.

Regulasi (Permenkes 24/2022, KMK 1423/2022) dapat diperbarui, sehingga sprint review berkala mampu menangkap pembaruan lebih cepat dibanding waterfall murni.

Stakeholder klinis (dokter penanggung jawab) bersedia berperan sebagai Product Owner paruh waktu.

Pendekatan hybrid ini bukan isapan jempol belaka. Kokol (2022) dalam jurnal Applied Sciences menyimpulkan bahwa proyek kesehatan jarang menerapkan agile secara utuh. Keselamatan pasien dan tuntutan kepatuhan seringkali memaksa tim untuk mengadopsi variasi hybrid, dan temuan itu sangat cocok dengan konteks kita.

Tentu saja, setiap metode punya sisi gelap. Dua kelemahan utama yang kami antisipasi adalah scope creep dan dokumentasi yang minim. Untuk mengatasi scope creep, kami membekukan backlog di setiap sprint; perubahan hanya bisa masuk melalui jalur formal, bukan sekadar obrolan ringan di sela-sela. Sedangkan untuk dokumentasi, meskipun agile cenderung mengabaikannya, kami mewajibkan dokumentasi API dan skema basis data di akhir setiap sprint. Dengan begitu, kami tetap lincah tanpa kehilangan jejak teknis. Sebuah keseimbangan yang tidak mudah, tapi harus dijalani.

Kelemahan & Antisipasi:

Scope creep: Godaan untuk menambahkan fitur di tengah jalan selalu ada, apalagi ketika pengguna mulai antusias dan melontarkan ide-ide baru. Tapi kami tidak membiarkan hal itu menggerogoti fokus. Setiap sprint menjadi pagar yang kokoh. backlog dibekukan setiap sprint, perubahan lingkup harus melalui change request formal.

Dokumentasi minim ciri khas agile: Agile memang terkenal mengabaikan dokumentasi karena mengutamakan perangkat lunak yang berjalan. Tapi bagi kami, itu risiko besar. Bayangkan jika di akhir proyek tidak ada catatan teknis yang jelas. Developer baru yang bergabung akan kebingungan, integrasi dengan SATUSEHAT menjadi teka-teki, dan pemeliharaan sistem berubah menjadi mimpi buruk. Karena itu, kami memasang aturan

19

tegas: dokumentasi API dan skema basis data harus diselesaikan di akhir setiap sprint.

Bukan dokumen setebal novel, tapi cukup untuk menjelaskan struktur dan alur data.

Dengan begitu, kelincihan tetap terjaga, tapi jejak teknis tidak hilang begitu saja. Sebuah kompromi yang menurut kami lebih bijak daripada sekadar mengandalkan ingatan atau kode yang tercecer.

Gambar 2.
5 Diagram Metodologi Hybrid Agile–Waterfall pada Proyek Pengembangan Sistem Rekam Medis Elektronik

C.2 Penjadwalan (Critical Path)

Kode	Aktivitas	Durasi (Hari)	Predecessor	Resource
---	---	---	---	---
A	Inisiasi & Rekrutmen	10	–	PM, Sponsor

| B | Desain Database & FHIR | 12 | A | Developer, PM |

| C | Setup VPS | 8 | A | DevOps Engineer |

| D | Impor ICD/KFA | 6 | C | Developer |

20

| E | Modul Pendaftaran | 18 | B, D | Developer, UI/UX Designer |

| --- | --- | --- | --- | --- |

| F | Modul SOAP | 22 | E | Developer, UI/UX Designer, SME |

| G | Farmasi & Billing | 10 | F | Developer |

| H | Integrasi BPJS | 15 | D, F | Developer, PM |

| I | Integrasi SATUSEHAT | 16 | F, H | Developer, PM |

| J | Pengujian & UAT | 14 | G, I | Semua Tim |

| K | Pelatihan & Go-Live | 8 | J | PM, SME |

Tabel 2.

2 Work Breakdown Schedule (WBS) Proyek Pengembangan Sistem

Mari kita bedah jadwalnya.

Sebelas aktivitas, dari A sampai K, masing-masing dengan durasi dan rantai ketergantungan yang saling mengunci.

A adalah langkah awal, 10 hari untuk inisiasi dan rekrutmen.

Dari sini, B dan C berjalan paralel.

B butuh 12 hari untuk desain basis data, C hanya 8 hari untuk setup VPS.

D, impor data kode, muncul setelah C dengan durasi 6 hari.

E menunggu B dan D, 18 hari.

F, modul SOAP, menjadi bintangnya.

22 hari, terpanjang.

Dari sini, aliran menyebar ke G (10 hari), H (15 hari untuk BPJS), dan I (16 hari untuk SATUSEHAT).

Setelah G dan I selesai, J menguji semua sistem selama 14 hari.

K menutup dengan 8 hari pelatihan dan go-live.

Jalur kritisnya: A-C-D-E-F-G-J-K. Totalnya 96 hari kerja.

Tapi kami tidak nekat.

Kami menambahkan buffer dan memperhitungkan hari libur.

Total menjadi 115 hari, atau 23 minggu.

Itulah kompromi antara target ideal dan kenyataan di lapangan.

21

Gambar 2.

6 Gantt Chart Jadwal Proyek Pengembangan Sistem Rekam Medis Elektronik

C.3 Estimasi Biaya Tiga Titik

| Modul | Optimis (O) | Realistis (M) | Pesimis (P) | Expected Time/Cost (TE) = (O + 4M + P) / 6 | Standar Deviasi (σ) = (P - O) / 6 |

| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| SOAP | Rp 12.000.000 | Rp 16.500.000 | Rp 22.000.000 | Rp 16.666.667 | Rp 1.666.667 |

| SATUSEHA T | Rp 8.000.000 | Rp 11.000.000 | Rp 18.000.000 | Rp 11.666.667 | Rp 1.666.667 |

| BPJS | Rp 6.000.000 | Rp 9.000.000 | Rp 14.000.000 | Rp 9.333.333 | Rp 1.333.333 |

Tabel 2.

3 Estimasi Biaya Pengembangan Modul Menggunakan Metode PERT

Mari kita hitung dengan pendekatan tiga titik.

Modul SOAP memiliki biaya optimis Rp12 juta, realistis Rp16,5 juta, dan pesimis Rp22 juta.

SATUSEHA T: optimis Rp8 juta, realistis Rp11 juta, pesimis Rp18 juta.

BPJS: optimis Rp6 juta, realistis Rp9 juta, pesimis Rp14 juta.

Dengan rumus $(O + 4M + P) / 6$, biaya yang diharapkan untuk ketiga modul adalah Rp37,67 juta.

Standar deviasi masing-masing Rp1,67 juta dan Rp1,33 juta.

Angka ini menunjukkan betapa

22

lebar rentang ketidakpastiannya, terutama pada modul integrasi yang bergantung pada API eksternal.

Gambar 2.

7 Gaji Rata-Rata Profesi IT

Kami menyiapkan dana kontingensi 10 persen dari total proyek, sekitar Rp11,3 juta.

Alasan utamanya sederhana: ketidakpastian API eksternal sangat tinggi.

Perubahan mendadak dari BPJS atau SATUSEHAT bisa terjadi kapan saja, dan kami harus siap menghadapinya.

Untuk sumber daya manusia, kami merekrut tim kecil selama 5 bulan.

Seorang full-stack developer dengan gaji Rp7,8 juta per bulan, total Rp39 juta.

Project manager paruh waktu juga Rp39 juta dalam 5 bulan.

UI/UX designer paruh waktu Rp10 juta dalam 5 bulan.

Dan DevOps engineer paruh waktu Rp12 juta dalam 5 bulan.

Total biaya SDM mencapai Rp100 juta.

23

| No. | Peran | Total Biaya (5 Bulan) |

	---	---	---
1	Full-stack Developer	Rp 39.000.000	
2	Project Manager (Paruh Waktu)	Rp 39.000.000	
3	UI/UX Designer (Paruh Waktu)	Rp 10.000.000	
4	DevOps Engineer (Paruh Waktu)	Rp 12.000.000	
Total	Biaya Sumber Daya Manusia (SDM)	Rp 100.000.000	

Tabel 2.
4 Estimasi Biaya Sumber Daya Manusia (SDM) Proyek

Gambar 2.
8 Harga Storage

Gambar 2.
9 Harga VPS

24

Biaya infrastruktur tahun pertama, mencakup VPS, backup, dan domain, sekitar Rp5.062.900.
Dengan rincian sebagai berikut:

Komponen	Spesifikasi	Biaya per Unit	Total per Tahun
---	---	---	---
VPS	Paket MM 8.4 (4 vCPU, RAM 8 GB, penyimpanan NVMe 60 GB)	Rp269.000/bulan	Rp3.228.000
Object Storage	Kapasitas 60 GB, Multi Region, kompatibel dengan API Amazon S3	Rp2.000/GB/bulan	Rp1.440.000
Domain	Domain .my.id	Rp9.900 (registrasi) + Rp35.000/bulan	Rp394.900
Total Biaya Infrastruktur			Rp5.062.900

Tabel 2.
5 Estimasi Biaya Infrastruktur Sistem per Tahun

Ditambah biaya tak terduga 10 persen sebesar Rp10,3 juta.
Total proyek menjadi Rp113 juta.
PPH 21 tidak masuk dalam anggaran karena dipotong langsung dari penghasilan pekerja.

Yang menarik, kami mewajibkan pair-programming berbasis AI menggunakan GitHub Copilot.
Bukan tanpa alasan.

Studi dari Peng, Kalliamvakou, Cihon, dan Demirer (2023) menemukan bahwa developer yang menggunakan Copilot menyelesaikan tugas pemrograman 55 persen lebih cepat dibandingkan kelompok kontrol. Temuan ini menjadi dasar realistis bagi kami untuk menargetkan durasi 5 bulan, meskipun tim tergolong kecil. Angka itu bukan sekadar optimisme, tapi perhitungan berbasis bukti.

Software cost estimation ranges from optimistic to pessimistic.

Gambar 2.
10 Diagram Estimasi Tiga Titik (PERT) untuk Estimasi Biaya Proyek

25

D. MANAJEMEN RISIKO & KUALITAS

D.1 Risk Register

Kode	Risiko	P	I	Skor	Strategi	Mitigasi	Trigger	Owner
---	---	---	---	---	---	---	---	---
R01	Dokter menolak sistem	4	5	20	Mitigasi	Libatkan sejak desain & pelatihan	Keluhan sistem lambat	PM
R02	Perubahan API SATUSEHAT	3	5	15	Mitigasi	Adapter pattern & monitor API	Versi API baru	Developer
R03	Kurang memahami FHIR	3	4	12	Mitigasi	Pelatihan & referensi FHIR	Banyak kendala implementasi	PM
R04	Internet tidak stabil	4	4	16	Mitigasi	Dual ISP & mode offline	Timeout	Admin IT
R05	Scope creep	3	3	9	Hindari	Scope freeze & change request	Permintaan fitur baru	PM
R06	Server down / data korup	2	5	10	Mitigasi	Backup harian & uji restore	Gagal sistem	DevOps
R07	Kode KFA/ICD tidak sesuai	2	4	8	Terima	Input manual & pembaruan kode	Error validasi	Developer

26

R08	Stok obat tidak diperbarui	3	3	9	Mitigasi	Pelatihan & alert stok	Selisih stok >5%	Farmasi
---	---	---	---	---	---	---	---	---
R09	Performa VPS menurun	2	4	8	Mitigasi	Load test & scale-up	Respons >3 detik	DevOps
R10	PM tidak penuh waktu	3	3	9	Mitigasi	Daily check-in & batasi proyek	Sprint gagal 2x	Sponsor

Tabel 2.
6 Risk Register Proyek Pengembangan Sistem

Software Project Risk Matrix

Gambar 2.

11 Matriks Probability–Impact Risiko Proyek Pengembangan Sistem Rekam Medis Elektronik

D.2 Expected Monetary Value (EMV)

R01: $0,4 \times \text{Rp } 11,2 \text{ jt} = \text{Rp } 4,48 \text{ juta}$

R04: $0,4 \times \text{Rp } 5 \text{ jt} = \text{Rp } 2,00 \text{ juta}$

R02: $0,3 \times \text{Rp } 1,56 \text{ jt} = \text{Rp } 0,47 \text{ juta}$

Total EMV = Rp 6,95 juta

Setelah menghitung nilai moneter yang diharapkan, total EMV mencapai Rp6,95 juta. Angka ini masih berada di bawah dana kontingensi Rp11,3 juta yang telah kami siapkan. Artinya, cadangan

27

risiko proyek tergolong memadai, setidaknya selama tidak ada kejutan tambahan di luar perkiraan.

Resistensi dokter tetap menjadi risiko dengan EMV tertinggi, yaitu Rp4,48 juta. Bhattacharjee dan Hikmet (2007) dalam European Journal of Information Systems mengingatkan bahwa penolakan dokter terhadap teknologi kesehatan tidak semata-mata soal kemampuan teknis. Faktor psikologis seperti persepsi ancaman terhadap otonomi klinis dan persepsi kegunaan sistem justru lebih dominan. Karena itu, strategi yang kami terapkan tidak berhenti pada pelatihan teknis biasa. Kami juga mengomunikasikan manfaat pribadi yang nyata, misalnya waktu pulang lebih cepat, dokumentasi yang lebih ringkas, dan beban administratif yang berkurang. Helpdesk WhatsApp dan video tutorial pendek menjadi pendukung penting, bukan sekadar pelengkap. Semua ini kami rancang untuk mengubah kekhawatiran menjadi keyakinan.

D.3 Rencana Manajemen Kualitas

Kualitas bukan sekadar tujuan akhir, melainkan proses yang harus dijaga sejak baris kode pertama ditulis. Kami mengacu pada standar internasional ISO/IEC 25010:2011, yang menjadi kerangka evaluasi kualitas perangkat lunak. Standar ini mencakup berbagai karakteristik, mulai dari kesesuaian fungsional, efisiensi performa, keandalan, kemudahan penggunaan, hingga keamanan. Semua menjadi pedoman dalam menilai setiap modul RME yang dibangun.

Quality Assurance (Pencegahan):

Daily code review / SonarQube untuk mendeteksi celah teknis sejak dini.

Linters PSR-12/PEP8 pada CI/CD untuk memastikan gaya kode tetap konsisten.

Acceptance criteria wajib untuk setiap user story.

GitHub Copilot sebagai akselerator penulisan kode, tetap direview manual oleh developer senior.

Quality Control (Pengujian):

Unit test (PHPUnit/Jest), coverage $\geq 70\%$ Unit test dengan PHPUnit dan Jest menargetkan cakupan kode minimal 70 persen.

Integration test dijalankan di lingkungan sandbox SATUSEHAT dan P-Care untuk memastikan koneksi berjalan mulus.

28

System test mencakup uji beban dengan JMeter untuk simulasi 10 pengguna virtual, serta uji keamanan menggunakan OWASP ZAP.

UAT oleh pengguna nyata dengan data dummy.

Kriteria Penerimaan Terukur:

Waktu respons < 2 detik.

Blocker = 0, major < 3.

SATUSEHAT sukses 100% dari 50 transaksi uji.

Restore < 30 menit.

Gambar 2.

12 Diagram Alur Quality Assurance pada Proyek Pengembangan Sistem Rekam Medis Elektronik

E. SDM, KOMUNIKASI, & PENGADAAN

E.1 Tim & Matriks RACI

Tim yang terlibat dalam proyek ini memang tidak besar, namun komposisinya cukup beragam. Ada Project Manager yang bekerja paruh waktu, seorang full-stack developer sebagai tulang punggung teknis, serta UI/UX designer dan DevOps engineer yang juga berstatus paruh waktu. Tidak ketinggalan, ada Subject Matter Expert dari internal klinik, yaitu dokter yang memahami alur pelayanan secara langsung. Sponsor yang menjabat sebagai direktur turut memberikan arahan strategis. Dan yang terakhir, admin IT klinik yang akan menjadi garda terdepan dalam pemeliharaan sistem sehari-hari.

29

Aktivitas	PM	DEV	UX	OPS	SME	SP	IT
	---	---	---	---	---	---	---
Desain ERD & FHIR	C	R	I	C	C	I	-
Setup VPS & Backup	I	-	-	R	-	I	C
Modul Pendaftaran	A	R	C	-	C	I	-

Modul SOAP	A	R	C	-	C	I	-
------------	---	---	---	---	---	---	---

Integrasi SATUSEHAT	A	R	-	-	I	-	-
---------------------	---	---	---	---	---	---	---

Pengujian UAT	A	R	-	-	R	I	C
---------------	---	---	---	---	---	---	---

Pelatihan Pengguna	R	I	-	-	C	I	R
--------------------	---	---	---	---	---	---	---

Go-Live Cutover	R	R	-	R	I	I	R
-----------------	---	---	---	---	---	---	---

Tabel 2.

7 Matriks RACI Proyek Pengembangan Sistem

Komposisi timnya sederhana.

Project Manager paruh waktu, seorang full-stack developer, UI/UX designer paruh waktu, dan DevOps engineer paruh waktu.

Ada juga SME dari internal dokter, sponsor, serta admin IT klinik.

Jumlahnya tidak banyak, tapi peran masing-masing cukup krusial.

R = Responsible, A = Accountable, C = Consulted, I = Informed

Analisis matriks menunjukkan DEV memikul beban kerja Responsible paling banyak.

Mitigasi: PM mengambil alih tugas non-coding (dokumentasi, koordinasi vendor) agar DEV fokus penuh pada pengembangan.

30

Gambar 2.

13 Matriks RACI Proyek Pengembangan Sistem Rekam Medis Elektronik

E.2 Rencana Komunikasi

Komunikasi	Frekuensi	Media	Audiens
------------	-----------	-------	---------

---	---	---	---
-----	-----	-----	-----

Kick-off Meeting	Awal proyek	Tatap muka / Zoom	Semua stakeholder
------------------	-------------	-------------------	-------------------

Daily Stand-up	Harian	WhatsApp / Slack	Tim inti
----------------	--------	------------------	----------

Sprint Planning	2 mingguan	Zoom	Tim inti, SME
-----------------	------------	------	---------------

Sprint Review	2 mingguan	Tatap muka / Zoom	Pengguna kunci
---------------	------------	-------------------	----------------

Laporan Proyek	Mingguan	Email / PDF	Sponsor, Admin IT
----------------	----------	-------------	-------------------

Steering Committee	Bulanan	Tatap muka	Sponsor, PM, SME
--------------------	---------	------------	------------------

Laporan Insiden	Sesuai kebutuhan	Telepon + Email	PM, Sponsor, Admin IT
-----------------	------------------	-----------------	-----------------------

Tabel 2.
8 Rencana Manajemen Komunikasi Proyek

31

E.3 Pengadaan

SOW Singkat: VPS 2 vCPU, 8 GB RAM, 120 GB NVMe, SLA 99,5%, dukungan 24/7, pusat data di Indonesia.
Object storage 50 GB (API kompatibel S3).
Kontrak 1 tahun.

Kebutuhan pengadaan cukup spesifik.
Kami mencari VPS dengan spesifikasi 2 vCPU, 8 GB RAM, dan penyimpanan NVMe 120 GB.
SLA minimal 99,5 persen, dengan dukungan teknis 24 jam dan pusat data di Indonesia.
Object storage 50 GB dengan API kompatibel S3 juga kami butuhkan, semuanya dalam kontrak satu tahun.

Kriteria Evaluasi Vendor: Harga (30%), kualitas teknis (40%), dukungan teknis (20%), reputasi (10%).
Ini bukan sekadar angka.
Bobot ini mencerminkan prioritas kami: stabilitas dan keandalan sistem lebih berharga daripada sekadar mengejar harga murah.

Jenis kontrak yang kami pilih adalah fixed price.
Alasannya sederhana.
Spesifikasi kebutuhan sudah dapat dipastikan sejak awal, sehingga model time and material justru berisiko membengkakkan biaya tanpa kendali.
Dengan fixed price, kami bisa mengunci anggaran dan menghindari kejutan di tengah jalan.
Keputusan yang bijak, menurut saya, untuk proyek sekecil ini.

F. IMPLEMENTASI, DEPLOYMENT, & PERUBAHAN

F.1 Strategi Go-Live: Big Bang

Big Bang.
Satu keputusan, satu loncatan.
Klinik ini kecil, hanya satu lokasi, dan selama ini masih bergantung pada kertas.
Maka kami memilih strategi Big Bang untuk go-live.
Mengapa?
Karena menjalankan dua sistem secara bersamaan, yang lama dan yang baru, hanya akan menguras tenaga staf yang sudah terbatas.
Pendekatan ini umum direkomendasikan pada studi implementasi sistem informasi kesehatan di fasilitas primer dengan sumber daya terbatas, di mana kompleksitas menjalankan dua sistem (lama dan baru) secara bersamaan justru menambah beban kerja staf yang sudah minim.

32

Jadwal Cutover (13 Desember 2026):

08.00 – Backup final

08.30 – Migrasi data master (Excel)

- 10.00 – Validasi sampel 20 data
- 11.00 – SATUSEHAT production + uji kirim
- 12.00 – Bridging BPJS aktif
- 13.00 – Briefing staf
- 14.00 – Sistem LIVE

Gambar 2.
14 Diagram Alur Cutover Go-Live Proyek Pengembangan Sistem Rekam Medis Elektronik

Jadwal cutover telah kami tetapkan pada 13 Desember 2026.
Pukul delapan pagi, backup final dilakukan.
Setengah jam kemudian, migrasi data master dari Excel dimulai.
Pukul sepuluh, kami memvalidasi 20 sampel data untuk memastikan semuanya berpindah dengan benar.
Satu jam berikutnya, giliran SATUSEHAT lingkungan produksi diuji kirim.
Pada siang hari, tepat pukul dua belas, bridging BPJS diaktifkan.
Kemudian briefing staf selama satu jam, dan pada pukul dua siang, sistem resmi hidup.
Semua berjalan dalam satu hari.
Terencana, terukur, dan tanpa setengah hati.

33

F.2 Migrasi Data

Sistem lama tidak ada, sehingga migrasi data berlangsung tanpa kerumitan integrasi antarplatform.
Kami mengandalkan arsip kertas yang berisi sekitar seribu data pasien.
Semua entri dimasukkan ke Excel terlebih dahulu, lalu diimpor menggunakan skrip Python.
Validasi dilakukan secara ketat, mencakup pengecekan duplikasi NIK dan format tanggal.
Jika ada kegagalan, prosedur rollback segera dijalankan.
Tabel dikosongkan, sementara berkas Excel sumber tetap utuh sebagai cadangan.
Tidak ada yang hilang, tidak ada yang tercecer.

F.3 Pelatihan & Change Management

Peran	Materi Pelatihan	Durasi
---	---	---
Dokter (2)	SOAP, e-Resep, Rujukan	4 jam
Perawat/Pendaftaran (2)	Pendaftaran, Tanda Vital, Alert	3 jam
Farmasi (1)	Antrean Resep, Manajemen Stok	2 jam
Admin IT (1)	User, Backup, Monitoring	2 jam

Tabel 2.

9 Rencana Pelatihan Pengguna Sistem

Sekarang beralih ke pelatihan dan manajemen perubahan.

Dokter mendapat porsi 4 jam, mencakup SOAP, e-resep, dan rujukan.

Perawat dan petugas pendaftaran hanya 3 jam, fokus pada pendaftaran, tanda vital, dan alarm.

Farmasi mendapat 2 jam untuk antrean resep dan manajemen stok.

Admin IT juga 2 jam, meliputi manajemen pengguna, backup, dan pemantauan.

Mengacu pada temuan Bhattacharjee & Hikmet (2007) bahwa persepsi kegunaan dan kemudahan menentukan penerimaan teknologi kesehatan oleh dokter, tim menyiapkan surat edaran yang menonjolkan manfaat pribadi (mis. pulang lebih cepat), video tutorial singkat (2 menit), dan helpdesk WhatsApp aktif selama satu minggu penuh. Statistik efisiensi waktu akan dipublikasikan setelah minggu pertama sebagai quick win untuk memperkuat penerimaan.

34

G. MONITORING, EVALUASI, & PENUTUPAN

G.1 Earned Value Management (Minggu ke-12)

Metrik	Nilai
--------	-------

---	---
-----	-----

BAC (Budget at Completion)	Rp 113.000.000
----------------------------	----------------

PV (Planned Value)	Rp 65.000.000
--------------------	---------------

EV (Earned Value)	Rp 55.000.000
-------------------	---------------

AC (Actual Cost)	Rp 63.000.000
------------------	---------------

SPI (Schedule Performance Index)	0,85
----------------------------------	------

CPI (Cost Performance Index)	0,87
------------------------------	------

Tabel 2.

10 Indikator Earned Value Management (EVM) Proyek

Estimate at Completion (EAC): a) $BAC/CPI = \text{Rp } 129.422.000$ b) $AC + (BAC - EV) = \text{Rp } 121.000.000$ c) $AC + (BAC - EV)/(CPI \times SPI) = \text{Rp } 141.590.000$ skenario terburuk

To-Complete Performance Index (TCPI):

Untuk mencapai BAC: $(58/50) = 1,16$.

Angka 1,16 itu tergolong sulit

Untuk EAC Rp 130 juta: $(75/67) = 1,12$.

Masih menantang namun lebih realistis.

Tiga metode perhitungan Estimate at Completion menghasilkan angka yang berbeda, masing-masing dengan asumsi yang unik.

Metode pertama menggunakan BAC dibagi CPI, menghasilkan Rp129,4 juta.
Metode kedua, AC ditambah selisih BAC dan EV, memberi angka Rp121 juta.
Dan metode ketiga, yang paling pesimis, menghitung AC ditambah (BAC dikurangi EV) dibagi hasil kali CPI dan SPI; hasilnya Rp141,6 juta.
Itulah skenario terburuk yang harus kami hadapi.

Pada skenario terburuk, biaya proyek berpotensi menembus Rp141,6 juta.
Itu melampaui dana kontingensi 10 persen yang kami siapkan.
Artinya, kami harus bergerak cepat dan cerdas.

35

Prioritaskan penyelesaian fitur Must, tunda dulu fitur Could yang tidak kritis, dan percepat integrasi yang masih tertunda, terutama BPJS dan SATUSEHAT.
Karena di situlah varian biaya terbesar bersembunyi.
Fokus, efisiensi, dan disiplin menjadi kunci agar proyek ini tidak tergelincir di ujung jalan.

Gambar 2.
15 Grafik Earned Value Management (EVM)

Proyek Pengembangan Sistem Rekam Medis Elektronik

G.2 Project Closure Checklist

Proyek rampung.
Bukan cuma selebrasi pamungkas.
Ada disiplin prosedural yang padat, yang tak bisa diabaikan begitu saja.
Soal administratif duluan.
Dokumen resmi dibentangkan: piagam proyek, cetak biru sistem, berikut panduan penggunaannya.
Berkas perikatan tenaga dan vendor dirapikan secara saksama (bagian ini kerap dianggap enteng, bukan?).
Rekening proyek dimatikan, lantas laporan fiskal final disusun secara cermat.
Dan, satu hal lagi yang krusial, notifikasi penutup meluncur ke seluruh pemangku kepentingan.
Biar tak ada yang merasa ditelantarkan.

36

Bicara soal teknis?
Beban nya tidak sedikit.
Kode sumber berikut seluruh repositori resmi beralih ke administrator IT.
Prosesi serah terima ini wajib dilengkapi dokumentasi API, cetak biru basis data, dan panduan deployment.
Kemudian, tahap pamungkas: deployment final ke lingkungan produksi.
Data uji kami lenyapkan.
Akun sandbox pun turut musnah.
Jangan sampai residu eksperimen mengusik sistem yang sudah berjalan.

Finansial.
Genting urusannya.
Audit varians biaya kami gelar.
Sasarannya gamblang: nihil celah, nihil kebocoran, tak secuil pun pengeluaran gentayangan tanpa catatan.
Pembayaran termin akhir kami tuntaskan tepat waktu.
Tanpa basa-basi.
Untuk manusianya, evaluasi kinerja individu kami sampaikan.
Umpan baliknya jujur, kadang pedas, tetapi selalu bertujuan membangun.
Dan surat rekomendasi bagi para pengembang kami racik dengan cermat.

Bukan sekadar formalitas, melainkan tanda mata yang tulus atas keringat dan lembur yang mereka tumpahkan.

Dan harta paling berharga?

Pelajaran dari pengembaraan ini.

Setiap kemenangan dan kekalahan kami abadikan.

Bukan dalam memori yang mudah luruh, melainkan dalam dokumentasi tertib yang siap diwariskan.

Ambil contoh integrasi SATUSEHAT.

Pola adaptor berhasil kami terapkan dengan mulus.

Namun waktu uji sandbox?

Terasa sangat sempit.

Membuat kami cukup kelimpungan, jujur saja.

Pengalaman itu kini menjadi guru yang getir.

Saran kami untuk proyek mendatang: sisihkan ruang gerak dua pekan khusus untuk pengujian eksternal.

Supaya tak ada lagi yang terjebak dalam lubang yang sama.

Berikut sejumlah hal yang patut dicermati:

1. Administratif

Serah terima dokumen charter/desain/user manual, arsip kontrak SDM & vendor, tutup rekening proyek, lapor pajak final, dan notifikasi penutupan ke stakeholder.

2. Teknis

Handover kode sumber (repositori) ke admin IT, dokumentasi API, skema DB, panduan deployment, deployment production final, hapus data uji & akun sandbox.

3. Finansial

Audit varians biaya dan pembayaran termin akhir.

4. SDM

Evaluasi kinerja & umpan balik individu, surat rekomendasi untuk developer.

37

G.3 Rencana Pemeliharaan (1 Tahun)

Setahun ke depan.

Sistem ini membutuhkan perawatan berkesinambungan.

Kami mematok SLA yang gamblang.

Insiden kritis?

Respons satu jam (standar yang cukup ketat, bukan?).

Tak bisa ditawar.

Penuntasannya: empat

Kom.

3 Tujuan Penulisan | 7 |

| BAB II ISI (PEMBAHASAN KASUS) | 8 |

| A. 3 Stakeholder & Power/Interest Grid | 12 |

| B. 3 Product Backlog (Agile, MoSCoW) | 17 |

| C. 3 Estimasi Biaya Tiga Titik | 22 |

| D. 3 Rencana Manajemen Kualitas | 28 |

| E. 32

F. 34

G. 40

3

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.
10

Gambar 2.
11

Gambar 2.
13

Gambar 2.
15

Gambar 2.
20

Gambar 2.
22

Gambar 2.
23

Gambar 2.
24

Gambar 2.
24

Gambar 2.
25

Gambar 2.

Gambar 2.
29

Gambar 2.
31

Gambar 2.
33

Gambar 2.
36

DAFTAR TABEL

Tabel 2.
1 Prioritas Pengembangan Fitur Menggunakan Metode MoSCoW 18

| --- | --- |

Tabel 2.
2 Work Breakdown Schedule (WBS) Proyek Pengembangan Sistem 21

Tabel 2.
3 Estimasi Biaya Pengembangan Modul Menggunakan Metode PERT 22

Tabel 2.
4 Estimasi Biaya Sumber Daya Manusia (SDM) Proyek 24

Tabel 2.
5 Estimasi Biaya Infrastruktur Sistem per Tahun 25

Tabel 2.
6 Risk Register Proyek Pengembangan Sistem 27

Tabel 2.
7 Matriks RACI Proyek Pengembangan Sistem 30

Tabel 2.
8 Rencana Manajemen Komunikasi Proyek 31

Tabel 2.
9 Rencana Pelatihan Pengguna Sistem 34

Tabel 2.
1 Latar Belakang Kasus

Bayangkan antrian pasien yang tak henti-henti di Klinik Pratama LKC DD; delapan puluh, sembilan puluh, terkadang seratus orang setiap harinya. Mereka bergiliran datang, sementara staf medis tetap berjuang dengan tumpukan berkas kertas yang mudah rusak, bahkan hilang. Sungguh risikonya mengerikan.

Obat rekam medis lenyap?

Apakah klaim BPJS ditolak karena catatan manual yang bertele-tele?

Itu hanya puncak gunung es.

Yang lebih mengkhawatirkan lagi adalah klinik ini nyaris siap menyambut gelombang regulasi digital yang sedang menggerakkan negeri ini.

Saya menyampaikan tentang Permenkes Nomor 24 Tahun 2022 dan KMK Nomor 1423 Tahun 2022.

Aturan dua ini tidak main-main, mewajibkan setiap fasilitas kesehatan, sekecil mana pun, harus mengintegrasikan datanya ke platform SATUSEHAT.

Tegas dan tak kompromi.

Di bawah tekanan yang demikian besar, pimpinan klinik akhirnya sampai pada titik keputusan yang krusial: membangun sistem rekam medis elektronik secara mandiri.

Bukan pilihan instan, melainkan sebuah keharusan.

Merancang modul yang cukup komprehensif mulai dari pendaftaran yang luwes, skrining dengan alarm darurat, SOAP terintegrasi dengan kode ICD, e-resep terhubung dengan farmasi, hingga billing yang efisien.

Yang tak kalah pentingnya juga: jembatan penghubung ke BPJS P-Care dan SATUSEHAT, tentunya dengan standar FHIR R4 yang terkini.

Namun, proyek sebesar ini pasti melibatkan banyak pihak, mulai dari dokter dan perawat hingga farmasi, bahkan lembaga pengawas seperti BPJS Kesehatan dan Kementerian Kesehatan.

Dengan sebanyak itu pemangku kepentingan, rasanya seperti menari di atas panggung yang ramai.

Kebutuhan akan pendekatan manajemen proyek yang terstruktur.

Jika target strategis tercapai, anggaran terkendali, tenggat waktu tidak molor, dan yang terpenting, kepatuhan regulasi serta kualitas layanan masih terjaga.

Studi kasus ini tidak hanya sekadar untuk mendokumentasikan langkah-langkah teknis.

Kami ingin menggali lebih dalam, menelusuri seluruh siklus proyek dari benih ide hingga sistem dapat berjalan.

Dari tahap inisiasi yang penuh pertimbangan, hingga penutupan proyek yang seringkali dilupakan begitu saja.

Sebagai kerangka pemikiran, kami mengacu pada PMBOK Guide edisi ketujuh yang diterbitkan oleh PMI (2021), sekaligus menyertakan temuan-temuan ilmiah terkini terkait penerapan rekam medis elektronik di fasilitas kesehatan primer.

Sebab, akhirnya,

6

keberhasilan proyek bukan hanya tentang kode, melainkan tentang kesiapan manusia, proses, dan kepatuhan yang tak berbelah-belah.

2 Rumusan Masalah

Dari penjelasan latar belakang tersebut, terdapat lima pertanyaan utama yang menjadi peta jalan studi kasus ini. Pertama, bagaimana proses inisiasi proyek dan analisis kelayakan disusun?

Bukan hanya soal angka-angka finansial, tetapi juga pertimbangan strategis yang memastikan proyek RME ini benar-benar layak dilakukan.

Kedua, bagaimanakah lingkup pekerjaan, jadwal, dan biaya dapat direncanakan secara realistis mengingat sumber daya klinis yang tidak terlalu besar?

Ini soal menyusun puzzle dengan potongan yang terbatas.

Ketiga, risiko dan kualitas biasanya menjadi momok dalam proyek seperti ini.

Bagaimana kedua-duanya dikelola untuk tidak mengganggu pelayanan klinis yang sudah berjalan?

Pasien tidak bisa menunggu, kan?

Keempat, sistem apa pun sekecil apa pun tidak akan berguna jika pengguna tidak mau menggunakannya.

Maka pertanyaan keempat mengusuk: bagaimana strategi implementasi, pelatihan, dan manajemen perubahan dirancang untuk memaksimalkan penerimaan, bahkan antusiasme, dari para pengguna?

Kedua, bagaimana proses pemantauan dan evaluasi kinerja proyek di tengah jalan, serta cara penutupan dilakukan agar tidak ada yang terlewat?

Rumusan masalah ini menjadi kompas untuk menuntut seluruh analisis dalam studi kasus ini, memastikan tidak ada sudut yang terlewat dari pengelolaan proyek yang kompleks dan krusial ini.

3 Tujuan Penulisan

Tujuan yang ingin dicapai dalam studi kasus ini cukup banyak, tetapi saling terkait.

Pertama-tama kami ingin menjelaskan seluruh proses inisiasi proyek.

Bukan hanya prosedur saja, tetapi juga penyusunan project charter dan analisis biaya manfaat yang menjadi dasar pengambilan keputusan investasi.

Sesiapa yang ingin rugi?

Oleh itu, semuanya perlu dihitung matang-matang.

Kedua, perencanaan lingkup kerjanya.

Kami akan memecahnya dengan Work Breakdown Structure dan scope statement.

Yang kedua, alat ini sebagai pagar pembatas agar ruang gerak proyek tidak terlalu lebar ke mana-mana.

Kemudian, kami menggambarkan metodologi yang telah dipilih, melacak jalur kritis penjadwalan, dan menghitung perkiraan biaya.

Untuk klinik

7

kecil, ketepatan waktu dan anggaran adalah nyawa proyek.

Analisis risiko dan rencana kualitas menjadi lapisan pertahanan selanjutnya.

Kita akan menelusuri keduanya secara mendalam, karena gangguan pada pelayanan klinis adalah harga mati yang tak boleh dibayar.

Di sisi lain, kita akan menggambarkan pengelolaan sumber daya manusia, komunikasi, dan pengadaan.

Ketiga pilar ini sering kali terabaikan, padahal justru menjadi penentu kelancaran sehari-hari.

Tak berhenti di situ.

Penyelesaian juga akan diberikan secara singkat mengenai strategi pelaksanaan, migrasi data, dan manajemen perubahan.

Bagaimana cara untuk membantu seluruh tim beradaptasi?

Tantangan itu tersendiri.

Dan sebagai langkah terakhir, kami akan mengevaluasi kinerja proyek dengan menggunakan Earned Value Management.

Kami juga membahas penutupan proyek serta pemeliharaan pasca implementasi karena sungguh-sungguh fase pemeliharaan merupakan awal dari perjalanan panjang sistem itu sendiri

BAB II ISI (PEMBAHASAN KASUS)

A. 1 Project Charter (Piagam Proyek)

Visi besar ini tidak sekadar omong-omong.

Klinik Pratama LKC DD memiliki cita-cita untuk berubah menjadi Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama yang modern, efisien, serta patuh terhadap aturan digital kesehatan nasional.

Dan itu tidak boleh menjadi pilihan.

Kewajiban ini langsung berasal dari Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis.

Aturannya sangat tegas: semua fasilitas kesehatan harus menyelenggarakan RME dan mengoneksikan datanya ke platform SATUSEHAT.

07/MENKES/1423/2022 juga mengatur pedoman variabel dan metadata yang harus diikuti.

Jadi ini bukan masalah gaya, tapi kepatuhan mutlak.

Penelitian lapangan di klinik-klinik pratama sejenis mengungkap fakta yang menarik, bahkan mengejutkan.

Ternyata kesiapan infrastruktur teknologi informasi menjadi faktor yang paling dominan.

Angkanya Odds Ratio mencapai 20,26.

Perbandingan dengan faktor SDM atau budaya kerja yang nilainya jauh lebih rendah.

Yakni infrastruktur bukan sekadar pelengkap, melainkan penentu utama.

Maka investasi dalam proyek ini bukan hanya soal membeli perangkat keras atau lunak saja.

Sebagai tambahan, investasi ini menjadi fondasi kepatuhan untuk

8

mendukung seluruh operasional klinik di masa depan.

Tanpa dasar itu, segala usaha itu tak lain adalah sia-sia.

Lalu apa yang akan dibangun?

Ruang lingkup tingkat tinggi telah dirancang.

Sistem RME berbasis web dengan modul yang cukup lengkap seperti pendaftaran yang fleksibel, bisa menerima NIK, paspor, SIM, bahkan pasien tanpa identitas.

Skrining tanda vital dilakukan secara manual, namun dilengkapi dengan alarm kegawatdaruratan yang cepat.

Modul SOAP menyediakan autocomplete untuk kode ICD-10 dan ICD-9-CM yang memudahkan dokter dalam menetapkan diagnosis.

E-resep terintegrasi langsung dengan Kamus Farmasi dan Alat Kesehatan (KFA), sedangkan input alergi menggunakan standar SNOMED CT.

Tersedia juga farmasi dan billing sederhana.

Yang tak kalah penting, sistem ini dilengkapi dengan bridging BPJS P-Care dan pengiriman data ke SATUSEHAT berbasis standar FHIR R4.

Infrastruktur pendukungnya juga disiapkan: VPS dengan spesifikasi 2 vCPU, RAM 8 GB, penyimpanan NVMe 120 GB, beserta backup harian terenkripsi yang disimpan di luar server.

Lengkap kan?

Namun perlu dicatatlah bahwa terdapat batasan eksplisit yang tidak termasuk dalam lingkup proyek.

Pasien tidak memiliki aplikasi seluler.

Tidak ada kios untuk pendaftaran mandiri.

Diskon, paket layanan, modul akuntansi lengkap, integrasi alat medis otomatis, atau layanan telemedicine juga tidak ada.

Keputusan ini diambil secara sadar untuk menjaga fokus dan efisiensi mengingat keterbatasan sumber daya yang dimiliki.

Faktor Keberhasilan Kritis

Kepatuhan mutlak.

Tanpa tawar-menawar.

Data diagnosis, tindakan, obat, dan alergi wajib meluncur ke SATUSEHAT dalam kondisi prima.
Tak boleh ada satu butir pun yang tercecer.
Begini kerasnya tuntutan interoperabilitas.

Adopsi pengguna.
Dua pekan pertama adalah masa genting.
Dokter dan perawat harus lekas akrab dengan sistem, dan lebih menantang lagi, tanpa mengorbankan produktivitas. (Mereka tetap melayani pasien dengan kecepatan yang sama, atau justru lebih efisien. Mampukah?)

Kestabilan terintegrasi dengan BPJS.
Downtime tidak boleh menembus satu persen.
Angkanya kecil, tetapi konsekuensinya ganas bila dilanggar.

9

Keamanan informasi.
Setiap backup harus berhasil.

Enkripsi data tersimpan menjadi benteng pamungkas, dan jejak audit harus tak terbantahkan.

Dan keempat pilar ini menjadi fondasi.
Penopang kepercayaan dari semua pihak.

Risiko Tingkat Tinggi

Resistensi dokter terhadap alur kerja baru.

Perubahan API SATUSEHAT secara mendadak.

Kompetensi developer pada standar FHIR/ICD.

Koneksi internet klinik yang labil.

Manajer proyek memegang peran sentral.
Wewenang yang diberikan cukup luas: mengelola anggaran dengan diskresi hingga 15 persen, merekrut atau mem-berhentikan tim kontrak, menyetujui perubahan lingkup selama masih di bawah 5 persen, dan berkomunikasi langsung dengan sponsor.
Ini adalah kepercayaan besar, tapi juga tanggung jawab yang berat.
Keputusan-keputusan strategis ada di tangannya, dan setiap langkah harus dipertimbangkan dengan cermat.

Gambar 2.
000

Tapi masih ada manfaat lain yang tidak terlihat, namun sama pentingnya.
Reputasi digital klinik ikut terdongkrak.
Proses audit jadi lebih mudah.
Pasien pun merasa lebih puas.
Staf tidak lagi sibuk mengurus pekerjaan administratif yang itu-itu saja, melainkan bisa lebih fokus melayani pasien secara langsung.
Itu nilai tambah yang sulit diukur dengan uang, tapi sangat teras.

000)

Payback Period: 1,57 tahun

ROI 3 tahun: 47%

Kesimpulannya?
LAYAK.

Keuntungan nyata menggulung ongkos operasional.

Dan ini yang kerap dilupakan: risiko sanksi administratif akibat ketidakpatuhan terhadap Permenkes 24/2022 justru jauh lebih menguras.)

bisa menimpa klinik yang lalai.

Balancing IT Project Costs and Benefits

Gambar 2.

2 Visualisasi Analisis Biaya dan Manfaat Proyek

11

Studi evaluasi ekonomi dari Singapura turut menegaskan.

Chen dan kawan-kawan (2025) dalam JMIR Medical Informatics membeberkan bahwa manfaat RME pada layanan primer memang hadir, meskipun dalam jangka pendek masih tergolong marginal.

Namun manfaat optimal baru beranjak ketika sistem sungguh-sungguh dimanfaatkan untuk memangkas duplikasi pemeriksaan yang kerap tak disadari itu.

dan mempercepat alur klaim.

Temuan ini sejalan dengan estimasi payback 1,57 tahun pada proyek kita, yang memang bertumpu pada efisiensi klaim dan peningkatan jumlah kunjungan pasien.

3 Stakeholder & Power/Interest Grid

Ada delapan pemain kunci dalam proyek ini.

Mereka bukan sekadar daftar nama, melainkan pihak-pihak yang punya kepentingan dan pengaruh besar terhadap jalannya sistem.

Mulai dari Direktur Klinik yang bertindak sebagai sponsor, Dokter Umum selaku DPJP, perawat dan petugas pendaftaran, farmasi, admin IT, BPJS Kesehatan cabang, Kementerian Kesehatan melalui platform SATUSEHAT, hingga pasien yang diwakili oleh perwakilannya.

Masing-masing punya peran yang tak bisa diabaikan.

8 Stakeholder Kunci:

Direktur Klinik (Sponsor)

Dokter Umum (DPJP)

Perawat/Pendaftaran

Farmasi

Admin IT

BPJS Kesehatan cabang

Kementerian Kesehatan (SATUSEHAT)

Pasien (perwakilan)

Sekarang, bagaimana strategi menghadapi mereka?
Kita bagi berdasarkan tingkat kekuasaan dan kepentingan.

Direktur dan dokter berada di kuadran paling kritis: kekuasaan tinggi, kepentingan tinggi.
Mereka harus dikelola secara intensif.
Laporan mingguan menjadi rutinitas yang tak bisa ditawar.
Bahkan, mereka punya hak veto terhadap desain antarmuka SOAP.
Suara mereka sangat menentukan.

12

Grid dan Strategi:

High Power, High Interest (Direktur, Dokter): kelola mereka dengan intens.
Mereka punya kuasa besar dan perhatian yang sangat tinggi terhadap proyek ini.
Laporan mingguan menjadi kewajiban rutin.
Dan yang menarik, mereka memegang hak veto terhadap desain antarmuka SOAP.
Setiap perubahan pada modul itu harus mendapat lampu hijau dari mereka.
Tanpa restu mereka, semua usaha hanya akan sia-sia.

High Power, Low Interest (Kemenkes, BPJS): Kementerian Kesehatan dan BPJS.
Kekuasaan mereka juga tinggi, tapi kepentingan terhadap detail teknis justru rendah.
Strategi yang tepat: jaga mereka tetap puas.
Patuhi regulasi tanpa banyak tawar-menawar.
Jangan pernah membebani mereka dengan urusan internal yang rumit.
Biarkan mereka fokus pada kepatuhan, bukan pada seluk-beluk kode.

Low Power, High Interest (Perawat, Farmasi, Admin IT): Mereka punya kepentingan tinggi, namun kekuasaan relatif rendah.
Mereka adalah ujung tombak operasional.
Beri mereka informasi secara teratur.
Daily standup selama 15 menit setiap hari.
Demo awal untuk menunjukkan alur sistem.
Survei umpan balik untuk menangkap keluhan dan saran mereka.
Karena mereka yang akan merasakan langsung setiap perubahan di lapangan.

Low Power, Low Interest (Pasien): Kekuasaan dan kepentingan mereka tergolong rendah dalam konteks pengembangan proyek.
Pemantauan dilakukan secara pasif melalui kotak saran dan pengukuran waktu tunggu.
Komunikasi tidak perlu intensif, cukup dengan papan informasi sederhana.
Mereka adalah konsumen akhir yang akan merasakan dampaknya, baik langsung maupun tidak langsung.

Gambar 2.
3 Pemetaan Stakeholder Berdasarkan Matriks Power-Interest

B. 1 Work Breakdown Structure

Mari kita bedah struktur rincian kerja proyek ini.
Ini adalah tulang punggung dari keseluruhan perencanaan.
Berikut struktur rincian kerja proyek ini:

1. Inisiasi Proyek

Semua dimulai dari fase inisiasi.
Di sini, tim menyusun piagam proyek dan kasus bisnis.
Ada riset regulasi yang mendalam, wawancara dengan berbagai pihak, penulisan dokumen yang ketat, dan tentu saja proses otorisasi.
Tidak berhenti sampai di situ, rekrutmen tim juga berjalan paralel.
Deskripsi pekerjaan disusun, lowongan dipasang, wawancara dilakukan, dan kontrak ditandatangani.
Dua langkah awal yang sangat menentukan.

2. Analisis & Desain

Ada tiga sub-bagian penting.
Pertama, analisis kebutuhan dengan memetakan alur klinis yang ada, mengidentifikasi celah-celah regulasi, dan merumuskan cerita pengguna.
Kedua, desain basis data.
Ini meliputi pembuatan ERD konseptual, normalisasi dan skema fisik, hingga skrip DDL untuk PostgreSQL.
Ketiga, desain antarmuka pengguna.

Mulai dari wireframe resolusi rendah hingga resolusi tinggi untuk lima layar kunci, yang kemudian divalidasi langsung oleh dokter.

Tahap ini adalah jembatan antara konsep dan implementasi.

3. Pengembangan Modul Inti

Ini adalah bagian yang paling luas dan memakan waktu.
Infrastruktur dan DevOps harus disiapkan terlebih dahulu: provisioning VPS, pengaturan PostgreSQL dengan RBAC dan backup, hingga CI/CD sederhana.
Data master diimpor dari berbagai sumber, termasuk ICD-10, ICD-9-CM, dan KFA.
Fungsi CRUD untuk pasien, dokter, dan obat juga dibangun, dengan dukungan identitas yang fleksibel.
Modul pendaftaran dan skrining dirancang dengan form pendaftaran yang efisien, pencatatan tanda vital disertai alarm darurat, dan antrean dokter yang diperbarui secara real-time.
Modul SOAP menjadi pusat dokumentasi klinis, dilengkapi autocomplete untuk kode diagnosis dan tindakan, e-resep berbasis KFA, serta input alergi menggunakan SNOMED CT.
Farmasi dan billing mengelola antrean resep

dan stok obat, serta menangani pembayaran tunai dan BPJS.
Integrasi dengan BPJS mencakup verifikasi SEP dan rujukan, baik FKTP maupun darurat.
Terakhir, integrasi SATUSEHAT melalui mapping FHIR, pengiriman data dan pencatatan log, serta dasbor pemantauan.

4. Pengujian

Setelah semua modul dibangun, pengujian dilakukan secara menyeluruh.

Ada unit test dan integration test, system test untuk performa dan keamanan, UAT yang melibatkan pengguna, dan uji sandbox dengan SATUSEHAT.

Semua harus berjalan mulus sebelum melanjutkan ke fase terakhir.

5. Deployment & Pelatihan

Migrasi data master dilakukan, pelatihan pengguna dijadwalkan, go-live dengan strategi Big Bang, dan hyper-care selama satu minggu penuh untuk memastikan transisi berjalan tanpa hambatan berarti.

Ini adalah momen yang paling mendebarkan, sekaligus paling menentukan.

Gambar 2.

2 Scope Statement

Mari kita bahas ruang lingkup pekerjaan secara tegas.

Ini adalah pagar pembatas yang akan menjaga proyek tetap berada di jalurnya.

Ada tujuh modul yang masuk dalam cakupan wajib.

Pertama, pendaftaran dengan identitas fleksibel, bisa menerima berbagai jenis dokumen identitas.

Kedua, skrining tanda vital yang dilengkapi dengan alarm darurat, mengacu pada kriteria gawat darurat sesuai Permenkes 47 Tahun 2018.

Ketiga, modul SOAP yang mendukung diagnosis dengan kode ICD-10, tindakan dengan ICD-9-CM, dan resep berbasis KFA.

Keempat, pencatatan riwayat alergi menggunakan standar SNOMED CT.

Kelima, bridging dengan BPJS untuk verifikasi SEP dan rujukan.

Keenam, pengiriman data ke SATUSEHAT melalui standar FHIR R4 dengan delapan jenis sumber daya, mulai dari Patient, Encounter, Condition, Procedure, MedicationRequest, AllergyIntolerance, hingga Practitioner.

Ketujuh, billing sederhana yang dilengkapi kwitansi.

In-Scope (7 modul wajib):

Pendaftaran dengan identitas fleksibel.

Skrining tanda vital & alert darurat (mengacu kriteria gawat darurat Permenkes 47/2018).

SOAP dengan diagnosis ICD-10, tindakan ICD-9-CM, resep KFA.

Riwayat alergi SNOMED CT.

Bridging BPJS (verifikasi SEP, rujukan).

Kirim data FHIR R4 ke SATUSEHAT (resource: Patient, Encounter, Condition, Procedure, MedicationRequest, AllergyIntolerance, Practitioner).

Billing sederhana + kwitansi.

Lalu, apa yang tidak masuk?

Ada beberapa hal yang sengaja dikeluarkan dari lingkup.

Tidak ada self-registration untuk pasien.

Tidak ada aplikasi seluler.

Diskon dan paket layanan juga tidak tersedia.
Integrasi dengan alat medis otomatis dan modul akuntansi penuh juga dikesampingkan.
Ini bukan kelalaian, melainkan keputusan sadar untuk menjaga fokus dan efisiensi.

Out-of-Scope:

Self-registration

Aplikasi seluler

16

Diskon

Integrasi alat medis

Akuntansi penuh.

Kriteria penerimaan pun disusun dengan jelas dan terukur.
Kepuasan pengguna dalam UAT harus mencapai minimal 80 persen.
Waktu respons sistem di bawah dua detik ketika diakses oleh delapan pengguna secara bersamaan.
Bug kategori blocker harus nol, sedangkan bug major tidak boleh lebih dari tiga sebelum go-live.
Pengiriman data ke SATUSEHAT harus berhasil seratus persen dari 50 sampel uji.
Dan proses pemulihan backup tidak boleh memakan waktu lebih dari 30 menit.
Semua angka ini menjadi tolok ukur keberhasilan.

Acceptance Criteria:

UAT pengguna: kepuasan ≥ 80%.

Waktu respons < 2 detik pada 8 pengguna bersamaan.

Blocker bug = 0, major < 3 sebelum go-live.

Kirim SATUSEHAT sukses 100% (50 sampel uji).

Restore backup < 30 menit.

3 Product Backlog (Agile, MoSCoW)

Sekarang beralih ke daftar prioritas produk dengan pendekatan Agile dan metode MoSCoW. Kategori Must berisi fitur yang mutlak harus ada: pendaftaran, skrining, SOAP, e-resep, billing, bridging BPJS, dan integrasi SATUSEHAT. Tanpa ini, sistem tidak bisa berfungsi sebagaimana mestinya.
Kategori Should mencakup fitur penting tapi tidak kritis: impor CSV, diagnosis favorit, dan dasbor SATUSEHAT.

17

| Prioritas | Item |

| --- | --- |

| Must | Pendaftaran, Skrining, SOAP, e-Resep, Billing, Bridging BPJS, SATUSEHAT |

| Should | Impor CSV, Diagnosis Favorit, Dashboard SATUSEHAT |

| Could | Preferensi Poli/DPJP, Laporan Harian |

| Won't | Diskon, Paket Layanan, Self-registration, Aplikasi Seluler, Integrasi Alat |

Tabel 2.

1 Prioritas Pengembangan Fitur Menggunakan Metode MoSCoW

Kategori Could berisi fitur tambahan yang bersifat pelengkap, seperti preferensi poli atau DPJP dan laporan harian. Sementara kategori Won't adalah fitur yang tidak akan dikerjakan, termasuk diskon, paket layanan, self-registration, aplikasi seluler, dan integrasi alat medis.

Semua ini adalah hasil diskusi tim yang matang.

Kita memilih untuk menjaga ruang lingkup tetap ramping, fokus pada proses bisnis inti yang sederhana namun penting: pendaftaran, pemeriksaan, pemberian obat, dan pembayaran. Itulah denyut nadi klinik yang harus kita layani dengan baik.

C.

1 Metodologi Hybrid (Agile-Waterfall)

Mengapa metode hybrid menjadi pilihan?

Bukan tanpa alasan.

Kami punya lima pertimbangan matang, dan semuanya bermuara pada satu titik: kebutuhan lapangan yang tak bisa dipaksa masuk ke satu kotak kaku.

Lima Alasan Pemilihan:

Kebutuhan klinis bersifat dinamis, membutuhkan sprint pendek untuk iterasi cepat.

Ukuran tim kecil (4-5 orang) lebih cocok dikelola dengan Scrum ringan.

Integrasi standar eksternal (FHIR, ICD, KFA) memerlukan spesifikasi yang kaku sejak awal.

Di situlah pendekatan waterfall kami pakai, terutama untuk desain basis data dan

18

pemetaan data.

Kami tidak bisa main-main dengan struktur tabel jika SATUSEHAT sudah menentukan formatnya.

Di sisi lain, regulasi seperti Permenkes 24/2022 dan KMK 1423/2022 juga berpotensi mengalami pembaruan.

Jika kami memakai waterfall murni, perubahan aturan di tengah jalan bisa menjadi bencana.

Maka, sprint review berkala menjadi kartu as kami untuk menangkap revisi aturan lebih cepat.

Regulasi (Permenkes 24/2022, KMK 1423/2022) dapat diperbarui, sehingga sprint review berkala mampu menangkap pembaruan lebih cepat dibanding waterfall murni.

Stakeholder klinis (dokter penanggung jawab) bersedia berperan sebagai Product Owner paruh waktu.

Pendekatan hybrid ini bukan isapan jempol belaka. Kokol (2022) dalam jurnal Applied Sciences menyimpulkan bahwa proyek kesehatan jarang menerapkan agile secara utuh.

Keselamatan pasien dan tuntutan kepatuhan seringkali memaksa tim untuk mengadopsi variasi hybrid, dan temuan itu sangat cocok dengan konteks kita.

Tentu saja, setiap metode punya sisi gelap. Dua kelemahan utama yang kami antisipasi adalah scope creep dan dokumentasi yang minim. Untuk mengatasi scope creep, kami membekukan backlog di setiap sprint; perubahan hanya bisa masuk melalui jalur formal, bukan sekadar obrolan ringan di sela-sela. Sedangkan untuk dokumentasi, meskipun agile cenderung mengabaikannya, kami mewajibkan dokumentasi API dan skema basis data di akhir setiap sprint. Dengan begitu, kami tetap lincah tanpa kehilangan jejak teknis. Sebuah keseimbangan yang tidak mudah, tapi harus dijalani.

Kelemahan & Antisipasi:

Scope creep: Godaan untuk menambahkan fitur di tengah jalan selalu ada, apalagi ketika pengguna mulai antusias dan melontarkan ide-ide baru. Tapi kami tidak membiarkan hal itu menggerogoti fokus. Setiap sprint menjadi pagar yang kokoh. backlog dibekukan setiap sprint, perubahan lingkup harus melalui change request formal.

Dokumentasi minim ciri khas agile: Agile memang terkenal mengabaikan dokumentasi karena mengutamakan perangkat lunak yang berjalan. Tapi bagi kami, itu risiko besar. Bayangkan jika di akhir proyek tidak ada catatan teknis yang jelas. Developer baru yang bergabung akan kebingungan, integrasi dengan SATUSEHAT menjadi teka-teki, dan pemeliharaan sistem berubah menjadi mimpi buruk.

Karena itu, kami memasang aturan

19

tegas: dokumentasi API dan skema basis data harus diselesaikan di akhir setiap sprint.

Bukan dokumen setebal novel, tapi cukup untuk menjelaskan struktur dan alur data.

Dengan begitu, kelincuhan tetap terjaga, tapi jejak teknis tidak hilang begitu saja. Sebuah kompromi yang menurut kami lebih bijak daripada sekadar mengandalkan ingatan atau kode yang tercecer.

Gambar 2.
2 Penjadwalan (Critical Path)

Kode	Aktivitas	Durasi (Hari)	Predecessor	Resource
---	---	---	---	---
A	Inisiasi & Rekrutmen	10	–	PM, Sponsor

| B | Desain Database & FHIR | 12 | A | Developer, PM |

| C | Setup VPS | 8 | A | DevOps Engineer |

| D | Impor ICD/KFA | 6 | C | Developer |

20

| E | Modul Pendaftaran | 18 | B, D | Developer, UI/UX Designer |

| --- | --- | --- | --- | --- |

| F | Modul SOAP | 22 | E | Developer, UI/UX Designer, SME |

| G | Farmasi & Billing | 10 | F | Developer |

| H | Integrasi BPJS | 15 | D, F | Developer, PM |

| I | Integrasi SATUSEHAT | 16 | F, H | Developer, PM |

| J | Pengujian & UAT | 14 | G, I | Semua Tim |

| K | Pelatihan & Go-Live | 8 | J | PM, SME |

Tabel 2.

2 Work Breakdown Schedule (WBS) Proyek Pengembangan Sistem

Mari kita bedah jadwalnya.

Sebelas aktivitas, dari A sampai K, masing-masing dengan durasi dan rantai ketergantungan yang saling mengunci.

A adalah langkah awal, 10 hari untuk inisiasi dan rekrutmen.

Dari sini, B dan C berjalan paralel.

B butuh 12 hari untuk desain basis data, C hanya 8 hari untuk setup VPS.

D, impor data kode, muncul setelah C dengan durasi 6 hari.

E menunggu B dan D, 18 hari.

F, modul SOAP, menjadi bintangnya.

22 hari, terpanjang.

Dari sini, aliran menyebar ke G (10 hari), H (15 hari untuk BPJS), dan I (16 hari untuk SATUSEHAT).

Setelah G dan I selesai, J menguji semua sistem selama 14 hari.

K menutup dengan 8 hari pelatihan dan go-live.

Jalur kritisnya: A-C-D-E-F-G-J-K. Totalnya 96 hari kerja.

Tapi kami tidak nekat.

Kami menambahkan buffer dan memperhitungkan hari libur.

Total menjadi 115 hari, atau 23 minggu.

Itulah kompromi antara target ideal dan kenyataan di lapangan.

21

Gambar 2.
333 |

Tabel 2.
3 Estimasi Biaya Pengembangan Modul Menggunakan Metode PERT

Mari kita hitung dengan pendekatan tiga titik.
Modul SOAP memiliki biaya optimis Rp12 juta, realistis Rp16,5 juta, dan pesimis Rp22 juta.
SATUSEHA T: optimis Rp8 juta, realistis Rp11 juta, pesimis Rp18 juta.
BPJS: optimis Rp6 juta, realistis Rp9 juta, pesimis Rp14 juta.

Dengan rumus $(O + 4M + P) / 6$, biaya yang diharapkan untuk ketiga modul adalah Rp37,67 juta.
Standar deviasi masing-masing Rp1,67 juta dan Rp1,33 juta.
Angka ini menunjukkan betapa

22
lebar rentang ketidakpastiannya, terutama pada modul integrasi yang bergantung pada API eksternal.

Gambar 2.
7 Gaji Rata-Rata Profesi IT

Kami menyiapkan dana kontingensi 10 persen dari total proyek, sekitar Rp11,3 juta.

Alasan utamanya sederhana: ketidakpastian API eksternal sangat tinggi.
Perubahan mendadak dari BPJS atau SATUSEHAT bisa terjadi kapan saja, dan kami harus siap menghadapinya.

Untuk sumber daya manusia, kami merekrut tim kecil selama 5 bulan.
Seorang full-stack developer dengan gaji Rp7,8 juta per bulan, total Rp39 juta.
Project manager paruh waktu juga Rp39 juta dalam 5 bulan.
UI/UX designer paruh waktu Rp10 juta dalam 5 bulan.
Dan DevOps engineer paruh waktu Rp12 juta dalam 5 bulan.
Total biaya SDM mencapai Rp100 juta.

23
| No. 000 |

Tabel 2.
4 Estimasi Biaya Sumber Daya Manusia (SDM) Proyek

Gambar 2.
8 Harga Storage

Gambar 2.
900. 900 |

Tabel 2.
5 Estimasi Biaya Infrastruktur Sistem per Tahun

Ditambah biaya tak terduga 10 persen sebesar Rp10,3 juta.

Total proyek menjadi Rp113 juta.
PPh 21 tidak masuk dalam anggaran karena dipotong langsung dari penghasilan pekerja.

Yang menarik, kami mewajibkan pair-programming berbasis AI menggunakan GitHub Copilot.
Bukan tanpa alasan.
Studi dari Peng, Kalliamvakou, Cihon, dan Demirer (2023) menemukan bahwa developer yang menggunakan Copilot menyelesaikan tugas pemrograman 55 persen lebih cepat dibandingkan kelompok kontrol.
Temuan ini menjadi dasar realistis bagi kami untuk menargetkan durasi 5 bulan, meskipun tim tergolong kecil.
Angka itu bukan sekadar optimisme, tapi perhitungan berbasis bukti.

Software cost estimation ranges from optimistic to pessimistic.

Gambar 2.

10 Diagram Estimasi Tiga Titik (PERT) untuk Estimasi Biaya Proyek

25

D. 1 Risk Register

Kode	Risiko	P	I	Skor	Strategi	Mitigasi	Trigger	Owner
---	---	---	---	---	---	---	---	---
R01	Dokter menolak sistem	4	5	20	Mitigasi	Libatkan sejak desain & pelatihan	Keluhan sistem lambat	PM
R02	Perubahan API SATUSEHAT	3	5	15	Mitigasi	Adapter pattern & monitor API	Versi API baru	Developer
R03	Kurang memahami FHIR	3	4	12	Mitigasi	Pelatihan & referensi FHIR	Banyak kendala implementasi	PM
R04	Internet tidak stabil	4	4	16	Mitigasi	Dual ISP & mode offline	Timeout	Admin IT
R05	Scope creep	3	3	9	Hindari	Scope freeze & change request	Permintaan fitur baru	PM
R06	Server down / data korup	2	5	10	Mitigasi	Backup harian & uji restore	Gagal sistem	DevOps
R07	Kode KFA/ICD tidak sesuai	2	4	8	Terima	Input manual & pembaruan kode	Error validasi	Developer

26

R08	Stok obat tidak diperbarui	3	3	9	Mitigasi	Pelatihan & alert stok	Selisih stok >5%	Farmasi
---	---	---	---	---	---	---	---	---
R09	Performa VPS menurun	2	4	8	Mitigasi	Load test & scale-up	Respons >3 detik	DevOps
R10	PM tidak penuh waktu	3	3	9	Mitigasi	Daily check-in & batasi proyek	Sprint gagal 2x	Sponsor

Tabel 2.

6 Risk Register Proyek Pengembangan Sistem

Software Project Risk Matrix

Gambar 2.

2 Expected Monetary Value (EMV)

R01: $0,4 \times \text{Rp } 11,2 \text{ jt} = \text{Rp } 4,48 \text{ juta}$

R04: $0,4 \times \text{Rp } 5 \text{ jt} = \text{Rp } 2,00 \text{ juta}$

R02: $0,3 \times \text{Rp } 1,56 \text{ jt} = \text{Rp } 0,47 \text{ juta}$

Total EMV = Rp 6,95 juta

Setelah menghitung nilai moneter yang diharapkan, total EMV mencapai Rp6,95 juta. Angka ini masih berada di bawah dana kontingensi Rp11,3 juta yang telah kami siapkan. Artinya, cadangan

27

risiko proyek tergolong memadai, setidaknya selama tidak ada kejutan tambahan di luar perkiraan.

Resistensi dokter tetap menjadi risiko dengan EMV tertinggi, yaitu Rp4,48 juta. Bhattacharjee dan Hikmet (2007) dalam European Journal of Information Systems mengingatkan bahwa penolakan dokter terhadap teknologi kesehatan tidak semata-mata soal kemampuan teknis. Faktor psikologis seperti persepsi ancaman terhadap otonomi klinis dan persepsi kegunaan sistem justru lebih dominan. Karena itu, strategi yang kami terapkan tidak berhenti pada pelatihan teknis biasa. Kami juga mengomunikasikan manfaat pribadi yang nyata, misalnya waktu pulang lebih cepat, dokumentasi yang lebih ringkas, dan beban administratif yang berkurang. Helpdesk WhatsApp dan video tutorial pendek menjadi pendukung penting, bukan sekadar pelengkap. Semua ini kami rancang untuk mengubah kekhawatiran menjadi keyakinan.

3 Rencana Manajemen Kualitas

Kualitas bukan sekadar tujuan akhir, melainkan proses yang harus dijaga sejak baris kode pertama ditulis.

Kami mengacu pada standar internasional ISO/IEC 25010:2011, yang menjadi kerangka evaluasi kualitas perangkat lunak.

Standar ini mencakup berbagai karakteristik, mulai dari kesesuaian fungsional, efisiensi performa, keandalan, kemudahan penggunaan, hingga keamanan.

Semua menjadi pedoman dalam menilai setiap modul RME yang dibangun.

Quality Assurance (Pencegahan):

Daily code review / SonarQube untuk mendeteksi celah teknis sejak dini.

Linters PSR-12/PEP8 pada CI/CD untuk memastikan gaya kode tetap konsisten.

Acceptance criteria wajib untuk setiap user story.

GitHub Copilot sebagai akselerator penulisan kode, tetap direview manual oleh developer senior.

Quality Control (Pengujian):

Unit test (PHPUnit/Jest), coverage $\geq 70\%$ Unit test dengan PHPUnit dan Jest menargetkan cakupan kode minimal 70 persen.

Integration test dijalankan di lingkungan sandbox SATUSEHAT dan P-Care untuk memastikan koneksi berjalan mulus.

28

System test mencakup uji beban dengan JMeter untuk simulasi 10 pengguna virtual, serta uji keamanan menggunakan OWASP ZAP.

UAT oleh pengguna nyata dengan data dummy.

Kriteria Penerimaan Terukur:

Waktu respons < 2 detik.

Blocker = 0, major < 3.

SATUSEHAT sukses 100% dari 50 transaksi uji.

Restore < 30 menit.

Gambar 2.

12 Diagram Alur Quality Assurance pada Proyek Pengembangan Sistem Rekam Medis Elektronik

E. 1 Tim & Matriks RACI

Tim yang terlibat dalam proyek ini memang tidak besar, namun komposisinya cukup beragam.

Ada Project Manager yang bekerja paruh waktu, seorang full-stack developer sebagai tulang punggung teknis, serta UI/UX designer dan DevOps engineer yang juga berstatus paruh waktu. Tidak ketinggalan, ada Subject Matter Expert dari internal klinik, yaitu dokter yang memahami alur pelayanan secara langsung. Sponsor yang menjabat sebagai direktur turut memberikan arahan strategis. Dan yang terakhir, admin IT klinik yang akan menjadi garda terdepan dalam pemeliharaan sistem sehari-hari.

29

Aktivitas	PM	DEV	UX	OPS	SME	SP	IT
---	---	---	---	---	---	---	---
Desain ERD & FHIR	C	R	I	C	C	I	-
Setup VPS & Backup	I	-	-	R	-	I	C

Modul Pendaftaran	A	R	C	-	C	I	-
-------------------	---	---	---	---	---	---	---

Modul SOAP	A	R	C	-	C	I	-
------------	---	---	---	---	---	---	---

Integrasi SATUSEHAT	A	R	-	-	I	-	-
---------------------	---	---	---	---	---	---	---

Pengujian UAT	A	R	-	-	R	I	C
---------------	---	---	---	---	---	---	---

Pelatihan Pengguna	R	I	-	-	C	I	R
--------------------	---	---	---	---	---	---	---

Go-Live Cutover	R	R	-	R	I	I	R
-----------------	---	---	---	---	---	---	---

Tabel 2.

7 Matriks RACI Proyek Pengembangan Sistem

Komposisi timnya sederhana.

Project Manager paruh waktu, seorang full-stack developer, UI/UX designer paruh waktu, dan DevOps engineer paruh waktu.

Ada juga SME dari internal dokter, sponsor, serta admin IT klinik.

Jumlahnya tidak banyak, tapi peran masing-masing cukup krusial.

R = Responsible, A = Accountable, C = Consulted, I = Informed

Analisis matriks menunjukkan DEV memikul beban kerja Responsible paling banyak.

Mitigasi: PM mengambil alih tugas non-coding (dokumentasi, koordinasi vendor) agar DEV fokus penuh pada pengembangan.

30

Gambar 2.

2 Rencana Komunikasi

Komunikasi	Frekuensi	Media	Audiens
------------	-----------	-------	---------

---	---	---	---
-----	-----	-----	-----

Kick-off Meeting	Awal proyek	Tatap muka / Zoom	Semua stakeholder
------------------	-------------	-------------------	-------------------

Daily Stand-up	Harian	WhatsApp / Slack	Tim inti
----------------	--------	------------------	----------

Sprint Planning	2 mingguan	Zoom	Tim inti, SME
-----------------	------------	------	---------------

Sprint Review	2 mingguan	Tatap muka / Zoom	Pengguna kunci
---------------	------------	-------------------	----------------

Laporan Proyek	Mingguan	Email / PDF	Sponsor, Admin IT
----------------	----------	-------------	-------------------

Steering Committee	Bulanan	Tatap muka	Sponsor, PM, SME
--------------------	---------	------------	------------------

Tabel 2.

3 Pengadaan

SOW Singkat: VPS 2 vCPU, 8 GB RAM, 120 GB NVMe, SLA 99,5%, dukungan 24/7, pusat data di Indonesia.

Object storage 50 GB (API kompatibel S3).

Kontrak 1 tahun.

Kebutuhan pengadaan cukup spesifik.

Kami mencari VPS dengan spesifikasi 2 vCPU, 8 GB RAM, dan penyimpanan NVMe 120 GB.

SLA minimal 99,5 persen, dengan dukungan teknis 24 jam dan pusat data di Indonesia.

Object storage 50 GB dengan API kompatibel S3 juga kami butuhkan, semuanya dalam kontrak satu tahun.

Kriteria Evaluasi Vendor: Harga (30%), kualitas teknis (40%), dukungan teknis (20%), reputasi (10%).

Ini bukan sekadar angka.

Bobot ini mencerminkan prioritas kami: stabilitas dan keandalan sistem lebih berharga daripada sekadar mengejar harga murah.

Jenis kontrak yang kami pilih adalah fixed price.

Alasannya sederhana.

Spesifikasi kebutuhan sudah dapat dipastikan sejak awal, sehingga model time and material justru berisiko membengkakkan biaya tanpa kendali.

Dengan fixed price, kami bisa mengunci anggaran dan menghindari kejutan di tengah jalan.

Keputusan yang bijak, menurut saya, untuk proyek sekecil ini.

F. 1 Strategi Go-Live: Big Bang

Big Bang.

Satu keputusan, satu loncatan.

Klinik ini kecil, hanya satu lokasi, dan selama ini masih bergantung pada kertas.

Maka kami memilih strategi Big Bang untuk go-live.

Mengapa?

Karena menjalankan dua sistem secara bersamaan, yang lama dan yang baru, hanya akan menguras tenaga staf yang sudah terbatas.

Pendekatan ini umum direkomendasikan pada studi implementasi sistem informasi kesehatan di fasilitas primer dengan sumber daya terbatas, di mana kompleksitas menjalankan dua sistem (lama dan baru) secara bersamaan justru menambah beban kerja staf yang sudah minim.

00 – Sistem LIVE

Gambar 2.

14 Diagram Alur Cutover Go-Live Proyek Pengembangan Sistem Rekam Medis Elektronik

Jadwal cutover telah kami tetapkan pada 13 Desember 2026.

Pukul delapan pagi, backup final dilakukan.

Setengah jam kemudian, migrasi data master dari Excel dimulai.

Pukul sepuluh, kami memvalidasi 20 sampel data untuk memastikan semuanya berpindah dengan benar.

Satu jam berikutnya, giliran SATUSEHAT lingkungan produksi diuji kirim.

Pada siang hari, tepat pukul dua belas, bridging BPJS diaktifkan.

Kemudian briefing staf selama satu jam, dan pada pukul dua siang, sistem resmi hidup. Semua berjalan dalam satu hari. Terencana, terukur, dan tanpa setengah hati.

2 Migrasi Data

Sistem lama tidak ada, sehingga migrasi data berlangsung tanpa kerumitan integrasi antarplatform. Kami mengandalkan arsip kertas yang berisi sekitar seribu data pasien. Semua entri dimasukkan ke Excel terlebih dahulu, lalu diimpor menggunakan skrip Python. Validasi dilakukan secara ketat, mencakup pengecekan duplikasi NIK dan format tanggal. Jika ada kegagalan, prosedur rollback segera dijalankan. Tabel dikosongkan, sementara berkas Excel sumber tetap utuh sebagai cadangan. Tidak ada yang hilang, tidak ada yang tercecer.

3 Pelatihan & Change Management

Peran	Materi Pelatihan	Durasi
---	---	---
Dokter (2)	SOAP, e-Resep, Rujukan	4 jam
Perawat/Pendaftaran (2)	Pendaftaran, Tanda Vital, Alert	3 jam
Farmasi (1)	Antrean Resep, Manajemen Stok	2 jam
Admin IT (1)	User, Backup, Monitoring	2 jam

Tabel 2.
9 Rencana Pelatihan Pengguna Sistem

Sekarang beralih ke pelatihan dan manajemen perubahan. Dokter mendapat porsi 4 jam, mencakup SOAP, e-resep, dan rujukan. Perawat dan petugas pendaftaran hanya 3 jam, fokus pada pendaftaran, tanda vital, dan alarm. Farmasi mendapat 2 jam untuk antrean resep dan manajemen stok. Admin IT juga 2 jam, meliputi manajemen pengguna, backup, dan pemantauan.

Mengacu pada temuan Bhattacharjee & Hikmet (2007) bahwa persepsi kegunaan dan kemudahan menentukan penerimaan teknologi kesehatan oleh dokter, tim menyiapkan surat edaran yang menonjolkan manfaat pribadi (mis. pulang lebih cepat), video tutorial singkat (2 menit), dan helpdesk WhatsApp aktif selama satu minggu penuh. Statistik efisiensi waktu akan dipublikasikan setelah minggu pertama sebagai quick win untuk memperkuat penerimaan.

G. 000	
SPI (Schedule Performance Index)	0,85
CPI (Cost Performance Index)	0,87

Tabel 2.
000 skenario terburuk

To-Complete Performance Index (TCPI):

Untuk mencapai BAC: $(58/50) = 1,16$.
Angka 1,16 itu tergolong sulit

Untuk EAC Rp 130 juta: $(75/67) = 1,12$.
Masih menantang namun lebih realistis.

Tiga metode perhitungan Estimate at Completion menghasilkan angka yang berbeda, masing-masing dengan asumsi yang unik.

Metode pertama menggunakan BAC dibagi CPI, menghasilkan Rp129,4 juta.

Metode kedua, AC ditambah selisih BAC dan EV, memberi angka Rp121 juta.

Dan metode ketiga, yang paling pesimis, menghitung AC ditambah (BAC dikurangi EV) dibagi hasil kali CPI dan SPI; hasilnya Rp141,6 juta.

Itulah skenario terburuk yang harus kami hadapi.

Pada skenario terburuk, biaya proyek berpotensi menembus Rp141,6 juta.
Itu melampaui dana kontingensi 10 persen yang kami siapkan.

Artinya, kami harus bergerak cepat dan cerdas.

35

Prioritaskan penyelesaian fitur Must, tunda dulu fitur Could yang tidak kritis, dan percepat integrasi yang masih tertunda, terutama BPJS dan SATUSEHAT.

Karena di situlah varian biaya terbesar bersembunyi.

Fokus, efisiensi, dan disiplin menjadi kunci agar proyek ini tidak tergelincir di ujung jalan.

Gambar 2.
2 Project Closure Checklist

Proyek rampung.

Bukan cuma selebrasi pamungkas.

Ada disiplin prosedural yang padat, yang tak bisa diabaikan begitu saja.

Soal administratif duluan.

Dokumen resmi dibentangkan: piagam proyek, cetak biru sistem, berikut panduan penggunaannya.).

Rekening proyek dimatikan, lantas laporan fiskal final disusun secara cermat.

Dan, satu hal lagi yang krusial, notifikasi penutup meluncur ke seluruh pemangku kepentingan.

Biar tak ada yang merasa ditelantarkan.

36

Bicara soal teknis?

Beban nya tidak sedikit.

Kode sumber berikut seluruh repositori resmi beralih ke administrator IT.

Prosesi serah terima ini wajib dilengkapi dokumentasi API, cetak biru basis data, dan panduan deployment.

Kemudian, tahap pamungkas: deployment final ke lingkungan produksi.

Data uji kami lenyapkan.

Akun sandbox pun turut musnah.

Jangan sampai residu eksperimen mengusik sistem yang sudah berjalan.

Finansial.

Genting urusannya.

Audit varians biaya kami gelar.

Sasarannya gamblang: nihil celah, nihil kebocoran, tak secuil pun pengeluaran gentayangan tanpa catatan.

Pembayaran termin akhir kami tuntaskan tepat waktu.

Tanpa basa-basi.

Untuk manusianya, evaluasi kinerja individu kami sampaikan.

Umpan baliknya jujur, kadang pedas, tetapi selalu bertujuan membangun.

Dan surat rekomendasi bagi para pengembang kami racik dengan cermat.

Bukan sekadar formalitas, melainkan tanda mata yang tulus atas keringat dan lembur yang mereka tumpahkan.

Dan harta paling berharga?

Pelajaran dari pengembaraan ini.

Setiap kemenangan dan kekalahan kami abadikan.

Bukan dalam memori yang mudah luruh, melainkan dalam dokumentasi tertib yang siap diwariskan.

Ambil contoh integrasi SATUSEHAT.

Pola adaptor berhasil kami terapkan dengan mulus.

Namun waktu uji sandbox?

Terasa sangat sempit.

Membuat kami cukup kelimpungan, jujur saja.

Pengalaman itu kini menjadi guru yang getir.

Saran kami untuk proyek mendatang: sisihkan ruang gerak dua pekan khusus untuk pengujian eksternal.

Supaya tak ada lagi yang terjebak dalam lubang yang sama.

Berikut sejumlah hal yang patut dicermati:

1. Administratif

Serah terima dokumen charter/desain/user manual, arsip kontrak SDM & vendor, tutup rekening proyek, lapor pajak final, dan notifikasi penutupan ke stakeholder.

2. Teknis

Handover kode sumber (repositori) ke admin IT, dokumentasi API, skema DB, panduan deployment, deployment production final, hapus data uji & akun sandbox.

3. Finansial

Audit varians biaya dan pembayaran termin akhir.

4. SDM

Evaluasi kinerja & umpan balik individu, surat rekomendasi untuk developer.

3 Rencana Pemeliharaan (1 Tahun)

Setahun ke depan.

Sistem ini membutuhkan perawatan berkesinambungan.

Kami mematok SLA yang gamblang.

Insiden kritikal?).

Tak bisa ditawar.

High Human Impact ● ● ● ● ● High AI Impact